ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

PSIQUIATRÍA GENERAL

90 preguntas de práctica

Salud Mental

MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Psiquiatría General · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

TOMO 17 · PARTE A: POR BLOQUES

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS					
4.01.1.001	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q3	Tomo 12 · 12.1 (Pág. 5)
5.01.1.004	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q4	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.007	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q5	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.008	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q6	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.009	Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q18	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.013	Dependencia de otras drogas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.015	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q7	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.020	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q8	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.021	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q9	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.022	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q10	Tomo 17 · 17.19 (Pág. 53)
5.01.1.023	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q11	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.024	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q12	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.028	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q13	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.029	Intento de suicidio en niños y adolescentes	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.032	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q14	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.033	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q15	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.034	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg:	GES	Q16	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		Completo			
5.01.2.001	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q17	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
BLOQUE 2: TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS					
1.03.1.003	Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q23, Q24, Q25, Q26	Tomo 17 · 17.6 (Pág. 24)
1.09.1.006	Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q30, Q31	Tomo 05 · 4.5 (Pág. 58)
1.11.1.002	Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q21, Q22	Tomo 17 · 17.4 (Pág. 17)
1.13.1.004	Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q34, Q35	Tomo 17 · 17.8 (Pág. 30)
5.01.1.001	Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q27, Q28, Q29	Tomo 17 · C.2 (Pág. 8)
5.01.1.002	Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q36	Tomo 17 · C.50 (Pág. 104)
5.01.1.003	Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q32	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.017	Disfunción sexual	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q19	Tomo 17 · 17.20 (Pág. 68)
5.01.1.035	Consumo perjudicial de drogas en niños y adolescentes	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q20	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.036	Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q33	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
BLOQUE 3: TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TOC & TRAUMA					
1.05.1.002	Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q38, Q39, Q40, Q41, Q45, Q46	Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11)
1.13.1.004	Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q47, Q48	Tomo 17 · 17.8 (Pág. 30)
5.01.1.005	Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q49	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.006	Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50, Q51, Q52, Q53, Q54	Tomo 17 · C.11 (Pág. 26)
5.01.1.010	Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q42, Q43, Q44	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.019	Sexualidad humana y sus alteraciones	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 17 · 17.20 (Pág. 68)
BLOQUE 4: TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS					

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.09.1.001	Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q67, Q68, Q69	Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37)
1.09.2.001	Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q62, Q63, Q64, Q65	Tomo 17 · 17.3 (Pág. 13)
1.13.2.001	Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q58, Q59, Q60, Q61	Tomo 17 · 17.13 (Pág. 45)
4.01.1.001	Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q56, Q57	Tomo 12 · 12.1 (Pág. 5)
5.01.1.012	Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q70	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.014	Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q71	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.025	Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q72	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.026	Enuresis	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q55	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.2.002	Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q66	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
BLOQUE 5: ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL					
1.09.1.001	Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q78, Q79	Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37)
4.01.1.001	Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q86, Q87	Tomo 12 · 12.1 (Pág. 5)
5.01.1.011	Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q74, Q75, Q76	Tomo 17 · 17.16 (Pág. 62)
5.01.1.016	Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q80, Q81, Q82, Q83, Q84, Q85	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.018	Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q88	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.027	Encopresis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q73	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.030	Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q89	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.031	Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q90	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.2.003	Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q77	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Psiquiatría General · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

TOMO 17 · PARTE B: ORDEN NUMÉRICO

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.03.1.003	Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q23, Q24, Q25, Q26	Tomo 17 · 17.6 (Pág. 24)
1.05.1.002	Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q38, Q39, Q40, Q41, Q45, Q46	Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11)
1.09.1.001	Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q67, Q68, Q69, Q78, Q79	Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37)
1.09.1.006	Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q30, Q31	Tomo 05 · 4.5 (Pág. 58)
1.09.2.001	Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q62, Q63, Q64, Q65	Tomo 17 · 17.3 (Pág. 13)
1.11.1.002	Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q21, Q22	Tomo 17 · 17.4 (Pág. 17)
1.13.1.004	Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q34, Q35, Q47, Q48	Tomo 17 · 17.8 (Pág. 30)
1.13.2.001	Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q58, Q59, Q60, Q61	Tomo 17 · 17.13 (Pág. 45)
4.01.1.001	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q3, Q56, Q57, Q86, Q87	Tomo 12 · 12.1 (Pág. 5)
5.01.1.001	Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q27, Q28, Q29	Tomo 17 · C.2 (Pág. 8)
5.01.1.002	Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q36	Tomo 17 · C.50 (Pág. 104)
5.01.1.003	Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q32	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.004	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q4	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.005	Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q49	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.006	Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50, Q51, Q52, Q53, Q54	Tomo 17 · C.11 (Pág. 26)
5.01.1.007	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q5	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.008	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q6	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
5.01.1.009	Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q18	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.010	Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q42, Q43, Q44	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.011	Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q74, Q75, Q76	Tomo 17 · 17.16 (Pág. 62)
5.01.1.012	Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q70	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.013	Dependencia de otras drogas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.014	Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q71	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.015	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q7	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.016	Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q80, Q81, Q82, Q83, Q84, Q85	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.017	Disfunción sexual	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q19	Tomo 17 · 17.20 (Pág. 68)
5.01.1.018	Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q88	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.019	Sexualidad humana y sus alteraciones	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 17 · 17.20 (Pág. 68)
5.01.1.020	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q8	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.021	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q9	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.022	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q10	Tomo 17 · 17.19 (Pág. 53)
5.01.1.023	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q11	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.024	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q12	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.025	Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q72	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.026	Enuresis	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q55	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.027	Encopresis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q73	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
5.01.1.028	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q13	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.029	Intento de suicidio en niños y adolescentes	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.030	Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q89	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.031	Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q90	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.032	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q14	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.033	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q15	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.034	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q16	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.035	Consumo perjudicial de drogas en niños y adolescentes	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q20	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.036	Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q33	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.2.001	Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q17	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.2.002	Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q66	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.2.003	Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q77	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS

PREGUNTA 1 5.01.1.013

1. **Un paciente consulta porque quiere dejar de fumar. Fuma cerca de 10 cigarrillos al día, especialmente cuando está más nervioso, los fines de semana y en las reuniones sociales. Disfruta del cigarrillo y no cree que podrá dejar de fumar sin apoyo. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este paciente?**

A) Terapia cognitiva conductual
B) Parches de nicotina
C) Bupropión
D) Fluoxetina
E) Vareniclina

PREGUNTA 2 5.01.1.029

2. **Una adolescente de 15 años se intenta suicidar, ingiriendo 600 miligramos de amitriptilina. ¿Cuál es el examen más adecuado para determinar su riesgo?**

A) Gases arteriales
B) Bilirrubinemia
C) Electrocardiograma
D) Creatinfosfoquinasa
E) Pruebas hepáticas

PREGUNTA 3 4.01.1.001

3. **Una mujer de 38 años consulta por un cuadro de 5 semanas de evolución caracterizado por ánimo persistentemente bajo, anhedonia, pérdida de 3 kg de peso, dificultad para concentrarse en su trabajo y despertar precoz con angustia matinal. Niega antecedentes mórbidos y su examen físico es normal. Se aplica escala PHQ-9 con resultado de 16 puntos. No presenta ideación suicida ni antecedentes personales o familiares de manía. ¿Cuál es la conducta terapéutica inicial más adecuada según la guía clínica GES?**

A) Indicar Clonazepam 1 mg cada 12 horas por 3 meses y control al término del tratamiento
B) Iniciar Sertralina 50 mg al día, asociar psicoterapia, educar sobre la latencia de 2 a 4 semanas y controlar en 2 semanas
C) Derivar inmediatamente a hospitalización psiquiátrica cerrada para inicio de terapia electroconvulsiva
D) Indicar reposo laboral exclusivo por 30 días sin iniciar psicofármacos hasta una segunda evaluación
E) Iniciar Amitriptilina 150 mg al día junto con Haloperidol 5 mg cada noche

PREGUNTA 4 5.01.1.004

4. **Un paciente de 35 años refiere sensación de angustia e inquietud, de un mes de evolución, asociado a insomnio de conciliación y cefalea diaria, de localización occipital, que se irradia hacia los hombros. Refiere que los síntomas iniciaron en relación a la necesidad de cambiarse de casa, ya que fue asignado a nuevo cargo en su trabajo, en una ciudad distinta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno por somatización
B) Depresión mayor
C) Trastorno conversivo
D) Trastorno adaptativo
E) Trastorno disociativo

PREGUNTA 5 5.01.1.007

5. **Un paciente de 43 años consulta por un cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por ánimo bajo, anhedonia, insomnio de conciliación y despertar precoz. Además, ha aumentado de peso y tiene pensamientos negativos e ideas recurrentes negativas sobre sí mismo, sin ideación suicida actual. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento en este paciente?**

A) Alprazolam
B) Sertralina
C) Quetiapina
D) Carbonato de litio
E) Amitriptilina

PREGUNTA 6 5.01.1.008

6. **Un hombre de 45 años consulta por ánimo deprimido, anhedonia, alteraciones del sueño y dificultades para concentrarse, los cuales han afectado su desempeño laboral y social durante los últimos 4 meses. No refiere antecedentes de episodios maníacos ni psicosis, pero sí un episodio depresivo mayor hace cinco años, tratado con éxito con fluoxetina. En esta ocasión, se inició tratamiento con escitalopram (20 mg/día) durante 4 semanas, pero no ha mostrado mejoría significativa en sus síntomas. No refiere efectos secundarios importantes con el medicamento y su función tiroidea y niveles de vitamina B12 y ácido fólico son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar la dosis de escitalopram
B) Cambiar el tratamiento a venlafaxina
C) Iniciar terapia electroconvulsiva (TEC)
D) Agregar un antipsicótico atípico como quetiapina
E) Cambiar el tratamiento a fluoxetina

PREGUNTA 7 5.01.1.015

7. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Trastornos neurocognitivos · 5.01.1.015] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Trastornos neurocognitivos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 8 5.01.1.020

8. **Una paciente de 39 años es despedida de su trabajo y, a las pocas horas, presenta imposibilidad de realizar movimientos con ambas manos. Al examen físico tiene tono muscular y reflejos normales. Además, llama la atención la falta de concordancia entre el relato de los síntomas y la actitud de la paciente, que se ve muy tranquila con lo que sucede. El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno dismórfico corporal

B) Trastorno conversivo

C) Trastorno facticio

D) Trastorno somatomorfo

E) Trastorno disociativo

PREGUNTA 9 5.01.1.021

9. **Una mujer de 18 años sufrió un rapto al salir de la oficina, por dos desconocidos. Es encontrada por terceras personas en un sitio eriazo, con evidentes signos de haber sido abusada sexualmente, sin lesiones físicas. Fue trasladada al Servicio Médico Legal, donde se constató la violación. Sin embargo, ella no recuerda nada de lo sucedido, recordando solo cuando fue abordada por los desconocidos y luego cuando estaba en el Servicio Médico Legal. Ella se muestra muy preocupada, pero no logra recordar nada de lo que aconteció entremedio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno conversivo

B) Trastorno de estrés postraumático

C) Trastorno facticio

D) Trastorno adaptativo

E) Trastorno disociativo

PREGUNTA 10 5.01.1.022

10. **Una paciente de 22 años es hospitalizada por un cuadro de diarrea, vómitos y dolor abdominal de difícil manejo. Durante la hospitalización es sorprendida ingiriendo laxantes, autoinduciéndose vómitos y adulterando la temperatura del termómetro. Se solicitan exámenes, descartándose patología orgánica. Además, luego de indagar, no se encuentra ninguna ganancia evidente con estos síntomas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno conversivo

B) Trastorno facticio

C) Trastorno delirante

D) Trastorno bipolar

E) Trastorno de la conducta alimentaria

PREGUNTA 11 5.01.1.023

11. **Un paciente de 20 años presenta episodios de descontrol y agresividad, en los que rompe objetos, grita, amenaza con agredir y con autoagredirse. Se molesta mucho cuando le cambian sus cosas de lugar y tiene rutinas muy marcadas, las que le cuesta mucho modificar. Abandonó la secundaria, ya que reprobó dos veces primero medio. Además, tiene muy buena memoria, al punto que puede memorizar los códigos de barras de distintos productos. Desde niño que fue considerado como raro, no entablaba amistades y jugaba solo siempre con el mismo juguete, además de ver repetidamente sus dos películas favoritas. Saluda a las personas de una manera extraña, con aleteo de sus extremidades superiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esquizofrenia

B) Trastorno bipolar

C) Trastorno de personalidad limítrofe

D) Trastorno del especto autista

E) Trastorno estereotipado del movimiento

PREGUNTA 12 5.01.1.024

12. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Trastorno específico del aprendizaje escolar · 5.01.1.024] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Trastorno específico del aprendizaje escolar. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 13 5.01.1.028

13. **Una mujer de 30 años, ingeniera civil, refiere que desde su infancia se le pierden con frecuencia las cosas y que le es diFcil realizar tareas, en especial porque las procras8na y le cuesta terminarlas una vez iniciadas. Por ello realiza listas de todas las cosas que debe hacer a modo de cumplir con ellas. Recientemente, en su trabajo ha aumentado su carga laboral y responsabilidades, lo que la 8ene agobiada y angus8ada. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Trastorno del espectro au2sta
B) Trastorno obsesivo compulsivo
C) Trastorno de personalidad
D) Trastorno por déficit atencional hiperac2vo
E) Trastorno de angus2a generalizada

PREGUNTA 14 5.01.1.032

14. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Trastorno somatización en niños · 5.01.1.032] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Trastorno somatización en niños. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 15 5.01.1.033

15. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Trastornos ansiosos en niños · 5.01.1.033] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Trastornos ansiosos en niños. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 16 5.01.1.034

16. **Un adolescente de 16 años presenta, desde hace 3 meses, anhedonia, disminución en su rendimiento escolar y presencia de pensamientos negativos sobre sí mismo y su situación, con aislamiento social. Además, relata dificultades para concentrarse en sus actividades académicas e insomnio tanto de inicio como de mantención. Ha subido 5 kilogramos de peso en los últimos meses. Niega autoagresiones y no tiene ideación suicida actual. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Distimia
B) Trastorno del espectro autista
C) Episodio depresivo mayor
D) Trastorno por déficit atencional
E) Trastorno de personalidad

PREGUNTA 17 5.01.2.001

17. **[URGENCIA: Conducta suicida · 5.01.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Conducta suicida. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 18 5.01.1.009

18. **Paciente de 35 años con episodios previos de tristeza profunda de 3 semanas de duración. Ahora consulta por irritabilidad, euforia, grandiosidad, insomnio sin cansancio y gastó todos sus ahorros en 4 días. ¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Trastorno bipolar tipo I
B) Trastorno depresivo mayor recurrente
C) Trastorno de ansiedad generalizada
D) Trastorno obsesivo compulsivo
E) Trastorno de personalidad borderline

BLOQUE 2 TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS

PREGUNTA 19 5.01.1.017

19. Una paciente de 33 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de dolor durante la penetración en las relaciones sexuales, por lo cual se ha negado a mantenerlas en el último mes. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno orgásmico femenino
B) Trastorno por dolor genito-pélvico/penetración
C) Trastorno depresivo mayor
D) Trastorno por somatización
E) Trastorno del deseo sexual hipoactivo

PREGUNTA 20 5.01.1.035

20. ¿Cuál es el riesgo principal del consumo de marihuana entre los 12 y los 18 años de edad?

A) Riesgo de dependencia a la marihuana
B) Riesgo de intoxicación aguda
C) Desarrollo de esquizofrenia
D) Disminución de la motivación escolar
E) Desarrollo de alcoholismo

PREGUNTA 21 1.11.1.002

21. Un hombre de 26 años consulta en el CESFAM por llanto fácil, insomnio de conciliación y desconcentración de 4 semanas de evolución. Refiere que hace 6 semanas terminó una relación de pareja de 3 años de duración. Al examen mental se aprecia angustiado, pero mantiene reactividad afectiva, sale a correr por las tardes, se alimenta bien y no presenta anhedonia generalizada ni ideas de muerte. Su PHQ-9 resulta en 6 puntos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta adecuada?

A) Trastorno depresivo mayor grave; iniciar Sertralina 100 mg al día e interconsulta a COSAM
B) Trastorno adaptativo con ánimo depresivo; indicar psicoterapia de apoyo breve y consejería sin psicofármacos
C) Trastorno de pánico; prescribir Clonazepam 2 mg cada 8 horas por 6 meses
D) Distimia crónica; indicar antidepresivos tricíclicos por 2 años
E) Trastorno bipolar tipo II; iniciar carbonato de litio inmediato

PREGUNTA 22 1.11.1.002

22. Una mujer de 39 años consulta en salud mental refiriendo: "Toda mi vida he sido una persona triste y sin energía; desde la universidad, hace más de 10 años, siento que veo el mundo en blanco y negro, me canso con facilidad y tengo muy baja autoestima". Refiere que nunca ha tenido episodios de euforia ni períodos libres de síntomas que superen las 3 o 4 semanas seguidas. Su examen físico y tiroideo son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el pilar terapéutico?

A) Trastorno adaptativo; reposo laboral exclusivo
B) Trastorno Depresivo Persistente (Distimia); tratamiento combinado con ISRS a largo plazo y psicoterapia cognitivo-conductual
C) Trastorno de personalidad esquizoide; tratamiento con antipsicóticos típicos
D) Episodio depresivo mayor único; suspensión de fármacos a los 3 meses
E) Trastorno ciclotímico; monoterapia con valproato sódico

PREGUNTA 23 1.03.1.003

23. Una mujer de 29 años llega al servicio de urgencias por tercera vez en el mes manifestando sensación de ahogo, opresión en el pecho, taquicardia y miedo inminente a morir, iniciado bruscamente hace 20 minutos mientras estaba sentada en su trabajo. Su ECG, hemograma, enzimas cardíacas y radiografía de tórax resultan normales. Relata que vive con angustia constante pensando cuándo volverá a repetirse el episodio y ha evitado salir sola a la calle. ¿Cuál es la estrategia farmacológica de mantenimiento más adecuada?

A) Indicar Alprazolam 0.5 mg cada 8 horas en monoterapia continua por un año
B) Iniciar Sertralina a dosis inicial de 25 mg al día titulando a 50 mg al día, asociar psicoterapia cognitivo-conductual y usar benzodiacepinas solo como puente transitorio
C) Prescribir Propranolol 80 mg cada 12 horas como monoterapia de por vida
D) Indicar Haloperidol 5 mg en gotas en caso de angustia y dar el alta sin controles
E) Mantener conducta expectante sin fármacos ya que todos los exámenes resultaron normales

PREGUNTA 24 1.03.1.003

24. Un hombre de 24 años consulta en urgencias por palpitaciones violently intensas, parestesias en dedos de las manos, temblor y sensación de atragantamiento que iniciaron hace 15 minutos. El examen cardiopulmonar y el ECG son rigurosamente normales. El médico tratante concluye que se trata de un ataque de pánico agudo. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado en la sala de urgencias?

A) Administrar Adenosina 6 mg endovenosa en bolo rápido
B) Realizar contención verbal, tranquilizar en box silencioso, entrenar respiración pausada y administrar Clonazepam 0.5 a 1 mg sublingual u oral si no cede
C) Indicar intubación orotraqueal por riesgo inminente de paro respiratorio
D) Administrar Morfina 10 mg subcutánea para calmar la sensación de opresión
E) Hacer respirar al paciente en una bolsa plástica herméticamente cerrada durante 15 minutos ininterrumpidos

PREGUNTA 25 1.03.1.003

25. Un paciente de 36 años con diagnóstico reciente de trastorno de pánico inicia tratamiento con Fluoxetina 20 mg/día. Al cuarto día acude muy alarmado al consultorio señalando que siente "más temblor, más palpitaciones y más angustia que antes de empezar las pastillas", pensando que el fármaco le hizo daño. ¿Cuál es la explicación neurobiológica y la conducta médica adecuada?

A) Es una reacción alérgica grave; suspender inmediatamente todo antidepresivo
B) Es una hiperactivación serotoninérgica 5-HT inicial transitoria; educar al paciente, reducir temporalmente la dosis a la mitad (10 mg) y considerar un ansiolítico puente
C) El paciente desarrolló un infarto agudo al miocardio; trasladar de inmediato a hemodinamia
D) El paciente finge los síntomas para obtener licencia; dar el alta sin indicaciones
E) Duplicar la dosis de Fluoxetina a 40 mg para vencer la resistencia

PREGUNTA 26 1.03.1.003

26. Una mujer de 40 años que sufrió múltiples ataques de pánico hace 6 meses ha dejado de utilizar el transporte público, no acude a centros comerciales ni supermercados, y únicamente sale a la puerta de su casa si va acompañada por su esposo, refiriendo pánico a "quedarse atrapada y no poder escapar si le viene una crisis". ¿Cuál es el diagnóstico complementario y el tratamiento psicoterapéutico más eficaz?

A) Trastorno delirante persecutorio; psicoterapia psicoanalítica
B) Agorafobia; Terapia Cognitivo-Conductual con técnicas de exposición interoceptiva y en vivo
C) Trastorno de personalidad obsesiva; hipnoterapia regresiva
D) Fobia social pura; relajación muscular progresiva exclusiva
E) Trastorno conversivo; hospitalización psiquiátrica prolongada

PREGUNTA 27 5.01.1.001

27. Una paciente presenta múltiples episodios de 5 minutos de duración, recurrentes, en los que presenta mucha angustia, llanto, sensación de ahogo, parestesias en las cuatro extremidades y marcado miedo a sufrir un infarto al corazón. Ya no sale de la casa por miedo a presentar uno de esos episodios en la calle. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno de pánico
B) Agorafobia
C) Trastorno de angustia generalizada
D) Trastorno de ansiedad social
E) Crisis de pánico

PREGUNTA 28 5.01.1.001

28. Una paciente de 28 años presenta un episodio de rápida instalación de marcada angustia y variados síntomas como disnea con "imposibilidad de sacar el aire", vértigo, parestesias en las extremidades, imposibilidad de tragar, opresión en el pecho, náuseas, visión borrosa y miedo a morir. En las últimas 4 semanas ha presentado varios episodios similares, por lo que teme salir de su casa. Su examen físico es normal y los exámenes generales descartan patología orgánica. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?

A) Amitriptilina 25 mg/día
B) Sertralina 50 mg/día
C) Risperidona 3 mg/día
D) Clonazepam 2 mg/día
E) Clorpromazina 300 mg/día

PREGUNTA 29 5.01.1.001

29. Una mujer de 45 años, hace 6 semanas mientras compraba, presenta un episodio de opresión en el pecho, disnea, vértigo, temor a morir, palpitaciones, disfagia, sensación de lipotimia, visión borrosa y disestesias de las extremidades superiores, asociado a marcada angustia. Desde entonces ha presentado un episodio de similares características cada semana. No tiene otros síntomas y su examen físico es normal, al igual que sus exámenes generales de laboratorio. ¿Cuál es el tratamiento de elección en el largo plazo?

A) Inhibidores de la monoaminoxidasa
B) Benzodiacepinas
C) Antipsicóticos atípicos
D) Antidepresivos tricíclicos
E) Inhibidores de la recaptura de serotonina

PREGUNTA 30 1.09.1.006

30. Una abogada de 34 años consulta por tensión muscular cervical continua, bruxismo, irritabilidad y preocupación excesiva por su desempeño laboral, sus finanzas y la salud de sus hijos, presente durante los últimos 8 meses. Refiere que le resulta imposible desconectarse de sus pensamientos y tarda más de 2 horas en conciliar el sueño. Su examen físico no muestra alteraciones neurológicas. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y el tratamiento de primera línea?

A) Crisis de pánico; Clonazepam 2 mg sublingual cada vez que sienta angustia
B) Trastorno de Ansiedad Generalizada; iniciar Escitalopram o Sertralina asociado a Terapia Cognitivo-Conductual
C) Trastorno de personalidad obsesiva; psicoterapia psicoanalítica exclusiva
D) Depresión psicótica; iniciar Haloperidol 5 mg al día
E) Fobia social; prescribir Propranolol diario matinal

PREGUNTA 31 1.09.1.006

31. Un estudiante universitario de 22 años consulta porque debe presentar su tesis de titulación frente a una comisión académica en dos semanas. Refiere que en su vida social habitual comparte normalmente con amigos y familia, pero cada vez que debe hablar frente a un público numeroso experimenta taquicardia violenta, temblor incontrolable en las manos, sudoración fría y rubor facial intenso que le impiden exponer. Niega síntomas ansiosos en su vida diaria. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta farmacológica más adecuada?

A) Trastorno de pánico; iniciar Sertralina 100 mg al día por 1 año
B) Fobia social circunscrita a la actuación en público; indicar Propranolol 10 a 40 mg vía oral 30 a 60 minutos antes de la disertación
C) Trastorno de ansiedad generalizada; indicar Clonazepam 2 mg diario
D) Trastorno adaptativo; indicar reposo médico y suspensión de la titulación
E) Agorafobia grave; iniciar Terapia Electroconvulsiva

PREGUNTA 32 5.01.1.003

32. Paciente de 28 años con miedo intenso y síntomas físicos ante situaciones de hablar en público o comer frente a otros. Evita reuniones sociales y ha rechazado ascensos laborales por esto. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea?

A) Escitalopram (ISRS)
B) Propranolol a demanda
C) Alprazolam a diario
D) Haloperidol
E) Carbamazepina

PREGUNTA 33 5.01.1.036

33. **Una mujer de 30 años se preocupa mucho por las finanzas y la salud de su familia. Además, le angustia que alguno de sus familiares pudiera quedarse sin trabajo o que la economía decayera. Refiere estar pasando por un periodo de estrés laboral y estar estresada porque muchas cosas dependen de ella, tanto en su trabajo, como en su familia. Refiere que en el último tiempo, lo único que la mantiene más tranquila es tomar un poco de clonazepam, el que consume 2 a 3 veces por semana. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno obsesivo compulsivo
B) Trastorno de pánico
C) Trastorno de personalidad dependiente
D) Reacción adversa a las benzodiazepinas
E) Trastorno de ansiedad generalizada

PREGUNTA 34 1.13.1.004

34. **Un hombre de 26 años consulta porque desde hace 6 meses siente la necesidad imperiosa de revisar la cerradura de la puerta de su departamento exactamente 12 veces antes de salir, por temor a que entren ladrones. Reconoce que esta conducta es ridícula y absurda, pero si intenta no realizarla experimenta una angustia intolerable. La rutina le hace llegar tarde a su trabajo a diario. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la psicoterapia de elección?**

A) Trastorno de la personalidad anancástico; psicoanálisis clásico
B) Trastorno Obsesivo-Compulsivo; Terapia Cognitivo-Conductual con Exposición y Prevención de Respuesta
C) Esquizofrenia paranoide incipiente; terapia ocupacional
D) Trastorno delirante celotípico; terapia familiar sistémica
E) Fobia social; desensibilización sistemática a la interacción

PREGUNTA 35 1.13.1.004

35. **Un paciente de 29 años con diagnóstico de TOC inició tratamiento con Fluoxetina 20 mg/día hace 4 semanas por indicación de médico general. En el control refiere no haber notado ninguna mejoría en sus rituales de orden y simetría, tolerando bien el medicamento. Pregunta si debe abandonar el tratamiento por ineficaz. ¿Cuál es la conducta médica correcta?**

A) Suspender la Fluoxetina y catalogar al paciente como refractario absoluto
B) Explicar que en el TOC se requieren dosis de ISRS más altas (titular Fluoxetina hasta 60 a 80 mg al día) y tiempos de espera de 8 a 12 semanas para evaluar la respuesta
C) Cambiar de inmediato a Clonazepam 2 mg cada 8 horas
D) Indicar internación inmediata en un hospital psiquiátrico cerrado
E) Asociar Haloperidol 10 mg al día en monoterapia

PREGUNTA 36 5.01.1.002

36. **Una paciente de 55 años, se lava las manos recurrentemente porque siente que se encuentran sucias, el hecho de no hacerlo rápidamente le provoca gran angustia. Esto le ha provocado dermatitis en sus manos, por lo cual está preocupada. Sabe que esta conducta no tiene sentido, pero no puede evitarlo. El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno de ansiedad
B) Ansiedad específica
C) Trastorno dismórfico corporal
D) Trastorno disociativo
E) Trastorno obsesivo compulsivo

BLOQUE 3 TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TOC & TRAUMA

PREGUNTA 37 5.01.1.019

37. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Sexualidad humana y sus alteraciones · 5.01.1.019] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Sexualidad humana y sus alteraciones. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 38 1.05.1.002

38. **Un joven de 20 años es llevado a la consulta médica por sus padres debido a que en los últimos 7 meses ha abandonado la universidad, se aísla en su habitación y afirma que una organización criminal lo espía a través de la televisión. En el examen mental se constata afecto aplanado, soliloquios y alucinaciones auditivas de voces que comentan lo que hace. El examen físico y el screening de drogas en orina son normales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y la conducta médico-legal más adecuada?**

A) Trastorno delirante crónico; manejo ambulatorio exclusivo en APS sin derivación
B) Primer Episodio de Esquizofrenia; activar Garantía Explícita en Salud (GES N° 34), iniciar antipsicótico atípico y derivar a confirmación por especialista
C) Trastorno esquizoafectivo; indicar Sertralina 100 mg y reposo en casa
D) Psicosis reactiva breve; esperar resolución espontánea antes de cumplir el mes
E) Trastorno de personalidad esquizotípico; indicar psicoterapia individual sin fármacos

PREGUNTA 39 1.05.1.002

39. Un paciente de 22 años diagnosticado de esquizofrenia inicia tratamiento con Haloperidol 5 mg cada 12 horas por vía oral. A las 24 horas de la primera dosis, es llevado a urgencias por presentar de forma brusca una desviación conjugada y sostenida de la mirada hacia arriba (crisis oculógira), contractura dolorosa intensa del cuello con inclinación lateral (tortícolis) y trismus mandibular. El paciente se encuentra angustiado pero plenamente vigil y afebril. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de elección inmediato?

A) Síndrome neuroléptico maligno; administrar dantroleno endovenoso urgente
B) Distonía aguda inducida por antipsicóticos; administrar Biperideno 5 mg intramuscular o endovenoso lento
C) Status epiléptico no convulsivo; administrar fenitoína en infusión rápida
D) Acatisia aguda; prescribir propranolol oral a permanencia
E) Tétanos generalizado; administrar toxoide antitetánico e inmunoglobulina

PREGUNTA 40 1.05.1.002

40. Un hombre de 26 años con esquizofrenia en tratamiento con Olanzapina 15 mg/día acude a control de salud a los 6 meses de terapia, manteniéndose sin síntomas psicóticos activos. En los exámenes de laboratorio destaca aumento de peso de 9 kg, glicemia en ayunas de 136 mg/dL (confirmada en segunda toma en 132 mg/dL) y triglicéridos en 280 mg/dL. ¿Cuál es la complicación que presenta y la conducta médica indicada?

A) Hipotiroidismo farmacológico; iniciar levotiroxina 100 mcg al día
B) Síndrome metabólico y diabetes mellitus inducidos por Olanzapina; indicar manejo dietético, metformina y evaluar rotación a un antipsicótico con menor perfil metabólico como Aripiprazol
C) Resistencia a antipsicóticos; duplicar la dosis de Olanzapina a 30 mg al día
D) Suspensión inmediata de todo tratamiento antipsicótico sin reemplazo
E) Insuficiencia suprarrenal secundaria; administrar hidrocortisona endovenosa

PREGUNTA 41 1.05.1.002

41. Un paciente de 24 años que presentó un primer episodio de esquizofrenia paranoide logra la remisión completa de sus ideas delirantes y alucinaciones tras 6 meses de tratamiento con Risperidona 3 mg/día. Se encuentra asintomático y ha retomado sus actividades cotidianas. Sus familiares preguntan cuánto tiempo debe continuar tomando el antipsicótico. Según las guías clínicas y la evidencia psiquiátrica, ¿cuál es la duración mínima recomendada del tratamiento de mantenimiento?

A) El medicamento puede suspenderse de inmediato ya que se logró la remisión completa
B) Debe mantenerse durante al menos 1 a 2 años continuos tras la remisión del primer episodio para evitar recaídas
C) Solo debe tomarlo en los días en que vuelva a escuchar voces
D) Debe suspenderse a las 4 semanas y reemplazarse por psicoterapia exclusiva
E) Debe mantenerse por 3 meses y luego usar únicamente benzodiacepinas

PREGUNTA 42 5.01.1.010

42. Un paciente de 26 años, estudiante universitario con regular rendimiento, es traído por sus padres porque desde hace tres meses no ha asistido a clases, ya que prefiere quedarse en su habitación. Ellos refieren que siempre fue solitario y que no buscaba tener amistades. Al entrevistarlo de forma dirigida se ríe sin motivo y refiere que no quiere salir de su habitación porque la voz del diablo lo amenaza. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno delirante crónico
B) Trastorno de la personalidad esquizoide
C) Delirium
D) Esquizofrenia hebefrénica
E) Trastorno Bipolar

PREGUNTA 43 5.01.1.010

43. Un paciente de 35 años está convencido que las vacunas contra la Covid-19 contienen un chip para rastrear a las personas y que hay un acuerdo entre Bill Gates y muchos de los gobiernos para controlar las mentes de la población, tal como lo ha hecho con muchas personas, a las que califica de "borregos". Cree que la mayoría de los médicos son parte de este complot, porque están financiados por las farmacéuticas y el Gobierno. Si bien se desenvuelve normalmente en su trabajo, ha tenido varios problemas con compañeros de trabajo y con sus familiares, cuando se toca el tema de las vacunas, en el que habla con gran vehemencia y certeza, criticando duramente a quienes le recomiendan vacunarse. También pierde mucho tiempo discutiendo sobre el tema en redes sociales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esquizofrenia
B) Trastorno delirante
C) Trastorno del espectro autista en el adulto
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno de personalidad paranoide (Nota: pregunta añadida a la reconstrucción) RECONSTRUCCIÓN EUNACOM AGOSTO 2021 Dr. Guillermo Guevara Aliaga SEGUNDA PARTE Instrucciones:

PREGUNTA 44 5.01.1.010

44. Un paciente de 21 años, abandonó a los 18 años su hogar, viviendo solo en la calle. Tiene la idea de ser un enviado de Dios, con la misión de salvar al mundo y dice que los ángeles le susurran al oído diciéndole cómo hacerlo. Los familiares refieren que empezó hace 3 años con esto y que no ha cambiado mucho desde entonces. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno delirante crónico
B) Esquizofrenia
C) Trastorno bipolar
D) Trastorno de personalidad esquizoide
E) Trastorno de conducta

PREGUNTA 45 1.05.1.002

45. **Un paciente de 28 años con esquizofrenia paranoide ha recibido tratamiento con Haloperidol 10 mg/día durante 8 semanas y posteriormente con Risperidona 6 mg/día durante 8 semanas, ambas con adherencia confirmada por sus cuidadores, persistiendo con alucinaciones auditivas agresivas e ideación delirante severa que le impiden salir a la calle. Su hemograma basal muestra leucocitos 6.500/mm³ con neutrófilos en 4.200/mm³. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y el tratamiento farmacológico de elección?**

A) Psicosis reactiva; suspender antipsicóticos e iniciar psicoterapia
B) Esquizofrenia refractaria; iniciar tratamiento con Clozapina bajo protocolo de monitorización hematológica
C) Trastorno bipolar maníaco; iniciar monoterapia con carbamazepina
D) Simulación de síntomas; dar el alta sin medicación
E) Esquizofrenia simple; rotar a Clorpromazina en dosis bajas

PREGUNTA 46 1.05.1.002

46. **Un paciente de 34 años con esquizofrenia refractaria en tratamiento con Clozapina 300 mg/día acude a su control en la semana 10 de terapia. Su hemograma de control protocolizado muestra leucocitos totales de 2.200/mm³ y Recuento Absoluto de Neutrófilos (RAN) de 790/mm³. El paciente no presenta fiebre ni síntomas infecciosos. ¿Cuál es la conducta médica inmediata e ineludible?**

A) Reducir la dosis de Clozapina a 150 mg al día y repetir el hemograma en un mes
B) Suspender de inmediato la Clozapina, hospitalizar en aislamiento protector y contraindicar la reexposición de por vida
C) Mantener la Clozapina e indicar amoxicilina profiláctica por vía oral
D) Asociar Biperideno 5 mg cada 12 horas para estimular la médula ósea
E) Asumir error de laboratorio, tranquilizar al paciente y mantener la dosis

PREGUNTA 47 1.13.1.004

47. **Una mujer de 32 años sufrió un accidente automovilístico grave hace 3 semanas en el cual falleció su acompañante. Desde hace 10 días presenta insomnio, llanto frecuente, sobresaltos intensos ante ruidos de motores y recuerdos intrusivos involuntarios del choque. Niega antecedentes psiquiátricos previos. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado en este momento?**

A) Trastorno de Estrés Postraumático crónico
B) Trastorno de Estrés Agudo
C) Esquizofrenia paranoide reactiva
D) Trastorno de pánico primario
E) Trastorno somatomorfo indiferenciado

PREGUNTA 48 1.13.1.004

48. **Un hombre de 40 años diagnosticado de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) tras haber sido víctima de secuestro hace 6 meses recibe tratamiento con Sertralina 100 mg/día y TCC. Si bien ha mejorado en su reactividad general durante el día, persiste con pesadillas aterradoras recurrentes en las que revive el encierro, despertando con diaforesis profusa y taquicardia todas las noches. ¿Cuál es el fármaco adyuvante con mayor evidencia específica para el control de las pesadillas en el TEPT?**

A) Prazosina
B) Diazepam
C) Haloperidol
D) Litio
E) Metilfenidato

PREGUNTA 49 5.01.1.005

49. **Paciente que presenció un asalto hace 2 semanas, ahora con angustia, irritabilidad, insomnio y estado de hiperalerta. ¿Diagnóstico más probable?**

A) Trastorno por estrés postraumático (TEPT)
B) Trastorno adaptativo con ansiedad
C) Trastorno por estrés agudo
D) Trastorno de pánico
E) Trastorno depresivo mayor

PREGUNTA 50 5.01.1.006

50. **Un paciente de 24 años, sin antecedentes, consulta porque hace ocho meses mientras esperaba transporte colectivo, presenció un accidente automovilístico con resultados fatales, desde entonces intenta no acercarse mucho a la calle y cada vez que está en un paradero se encuentra muy inquieto, además refiere que le cuesta conciliar el sueño ya que presenta pesadillas frecuentemente. El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno por estrés post traumático
B) Trastorno de ansiedad
C) Trastorno evitativo
D) Trastorno por estrés agudo
E) Trastorno adaptativo

PREGUNTA 51 5.01.1.006

51. **Un paciente de 50 años, presentó una pelea con su vecino hace 4 meses y desde hace un mes comienza con recuerdos del incidente, asociado a pesadillas recurrentes. En las últimas semanas evita pasar por fuera de la casa de su vecino por miedo, y su familia refiere que se encuentra con ánimo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno adaptativo
B) Trastorno de estrés postraumático
C) Depresión reactiva
D) Depresión psicótica
E) Trastorno de ansiedad generalizada

PREGUNTA 52 5.01.1.006

52. **Psicofármaco contraindicado en trastorno de estrés post traumático**

A) benzodiazepinas
B) ISRS
C) Triciclicos
D) Antipsicoticos tipicos
E) Antipsicóticos atípicos

PREGUNTA 53 5.01.1.006

53. **Una paciente de 52 años, con antecedente de abuso sexual reiterado por un familiar, entre los 12 y los 15 años, del que aún mantiene recuerdos y pesadillas, refiere episodios de algunos días de duración ánimo irritable y lábil, asociada a ira y peleas con sus familiares, con llanto y agresividad. En ocasiones, presenta episodios de hasta dos días de duración de descontrol y rabia, en los que rompe ropa y electrodomésticos de su marido. Estos episodios le traen problemas con sus cercanos y, en algunas ocasiones, son muy intensos, en especial cuando se expone a conversaciones relacionadas con el tema, en los que llora, siente intensa angustia, grita e incluso ha presentado momentos en que actúa como una niña, con lenguaje y entonación de una menor de edad. Estos episodios cursan con amnesia de lo sucedido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno bipolar
B) Trastorno delirante
C) Trastorno esquizoafectivo
D) Trastorno conversivo
E) Trastorno de estrés postraumático

PREGUNTA 54 5.01.1.006

54. **Un paciente de años, desde hace 10 días comienza con angustia y malestar general, asociado a dificultades para dormir y pesadillas. Se ha sentido agobiado y triste. Refiere que ace dos semanas fue testigo de un asalto, en el cual la víctima fue herida con un arma de fuego. Además, ha evitado salir de su casa y el contacto con otras personas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno agudo por estrés
B) Episodio depresivo mayor
C) Trastorno de estrés postraumático
D) Trastorno de angustia generalizada
E) Trastorno de angustia social

BLOQUE 4 TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

PREGUNTA 55 5.01.1.026

55. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Enuresis · 5.01.1.026] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Enuresis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 56 4.01.1.001

56. **Una mujer de 48 años, ingeniera en sistemas con excelente desempeño laboral, acude al cuartel de policía y posteriormente a la posta médica denunciando que sus vecinos de departamento han taladrado microscópicamente el piso para introducir gas tóxico que le causa ardor en la piel al dormir. Al examen mental se presenta pulcra, colaboradora, con discurso fluido y coherente, sin alteraciones del lenguaje ni síntomas negativos, y niega escuchar voces. El cuadro lleva 4 meses de evolución sin deterioro en otras áreas de su vida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esquizofrenia paranoide avanzada
B) Trastorno Delirante Crónico tipo persecutorio/somático
C) Trastorno psicótico breve reactivo
D) Demencia frontotemporal incipiente
E) Trastorno de ansiedad generalizada

PREGUNTA 57 4.01.1.001

57. **Un comerciante de 38 años sin antecedentes psiquiátricos pierde su local comercial en un incendio intencional. A los dos días comienza con agitación psicomotora, insomnio total, llanto incontrolable y afirmaciones de que "ve demonios que le ordenan caminar en círculos". Es hospitalizado y tratado transitoriamente con dosis bajas de Risperidona. Al día 18 del cuadro, los síntomas psicóticos desaparecen por completo, encontrándose orientado, reflexivo y reincorporándose plenamente a sus actividades comerciales. ¿Cuál es el diagnóstico retrospectivo definitivo?**

A) Esquizofrenia hebefrénica
B) Trastorno Psicótico Breve con desencadenante grave
C) Trastorno esquizofreniforme residual
D) Trastorno de personalidad límite
E) Trastorno bipolar en manía pura

PREGUNTA 58 1.13.2.001

58. **Un paciente de 29 años con esquizofrenia en tratamiento hospitalario con Haloperidol 15 mg/día presenta fiebre de 39.5 °C, diaforesis profusa, presión arterial fluctuante entre 160/100 y 90/60 mmHg, taquicardia de 125 lpm y estupor. Al examen físico destaca rigidez muscular generalizada en caño de plomo. El laboratorio urgente informa leucocitos de 21.000/mm³ y CPK en 14.200 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la primera medida que debe implementarse?**

A) Meningitis bacteriana aguda; iniciar Ceftriaxona y Vancomicina manteniendo el antipsicótico
B) Síndrome Neuroléptico Maligno; suspender de inmediato el Haloperidol e iniciar hidratación endovenosa masiva y traslado a UPC
C) Distonía laríngea aguda; administrar Biperideno 5 mg intramuscular
D) Síndrome serotoninérgico; administrar Ciproheptadina oral exclusiva
E) Catatonía periódica benigna; aumentar la dosis de Haloperidol a 30 mg al día

PREGUNTA 59 1.13.2.001

59. **Un paciente de 35 años que consume Paroxetina 40 mg/día por depresión acude a urgencias tras ingerir 200 mg de Tramadol por un lumbago agudo. A las pocas horas presenta agitación psicomotora, diarrea acuosa profusa, temblor y fiebre de 38.6 °C. Al examen físico destaca midriasis bilateral reactiva, taquicardia de 120 lpm, hiperreflexia osteotendinosa patológica generalizada (4+) y clonus inducible en ambos tobillos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial correcto frente al síndrome neuroléptico maligno?**

A) Síndrome Neuroléptico Maligno; cursa con clonus e hiperreflexia
B) Síndrome Serotoninérgico; caracterizado por la presencia distintiva de hiperreflexia, clonus y diarrea por exceso de serotonina
C) Intoxicación colinérgica por organofosforados
D) Tétanos generalizado cefálico
E) Crisis tirotóxica aguda

PREGUNTA 60 1.13.2.001

60. **¿Cuál es el objetivo fisiopatológico fundamental de la hidratación endovenosa masiva con solución fisiológica en el manejo de un paciente con Síndrome Neuroléptico Maligno y CPK de 22.000 UI/L?**

A) Aumentar la litemia plasmática para estabilizar el ánimo
B) Garantizar una diuresis forzada de 2 a 3 mL/kg/hora para prevenir la necrosis tubular aguda y la falla renal por mioglobinuria
C) Inducir hiponatremia dilucional para frenar las contracciones musculares
D) Disminuir la presión intracraneana mediante hemodilución osmótica
E) Favorecer la excreción hepática del antipsicótico vía biliar

PREGUNTA 61 1.13.2.001

61. **Un paciente ingresado en la UCI con diagnóstico de Síndrome Neuroléptico Maligno grave persiste con temperatura de 40.2 °C y rigidez generalizada severa a pesar de 6 horas de suspensión de neurolépticos, enfriamiento físico e hidratación intensa. Se decide iniciar farmacoterapia específica de rescate. ¿Cuál de los siguientes esquemas farmacológicos es el indicado en esta situación?**

A) Dantroleno sódico endovenoso y/o Bromocriptina por sonda nasogástrica
B) Flumazenil endovenoso en bolo continuo
C) Naloxona subcutánea seriada
D) Haloperidol en infusión continua de baja dosis
E) Ciproheptadina oral exclusiva

PREGUNTA 62 1.09.2.001

62. **Un hombre de 24 años con esquizofrenia paranoide descompensada ingresa a urgencias en estado de extrema agitación psicomotora, amenazando físicamente al equipo médico y arrojando mobiliario. Tras fracasar la contención verbal, se decide realizar contención física mecánica transitoria y administrar fármacos parenterales de rescate. ¿Cuál es la combinación farmacológica intramuscular más segura, eficaz y recomendada para el control rápido de la agitación en urgencias?**

A) Haloperidol 5 mg IM asociado a Lorazepam 2 mg IM
B) Olanzapina 10 mg IM asociada a Lorazepam 4 mg IM en la misma jeringa
C) Morfina 10 mg IM asociada a Diazepam 10 mg IM
D) Fenobarbital 200 mg IM en monoterapia
E) Biperideno 10 mg IM asociado a Clorpromazina 100 mg EV directo

PREGUNTA 63 1.09.2.001

63. Un anciano de 82 años hospitalizado en medicina interna al segundo día postoperatorio de fractura de cadera presenta bruscamente en horas de la noche agitación, desorientación témporo-espacial, alucinaciones visuales viendo animales en el techo e intentos reiterados de arrancarse la vía venosa y la sonda Foley. Sus signos vitales son estables y el hemoglucotest es de 110 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y el manejo farmacológico de elección en caso de requerir sedación?

A) Crisis de angustia; administrar Alprazolam 2 mg sublingual
B) Delirium hiperactivo orgánico; buscar y corregir la causa desencadenante y usar Haloperidol a dosis bajas (0.5 a 1 mg VO/IM) si hay riesgo físico
C) Debut de esquizofrenia tardía; iniciar Risperidona 6 mg al día
D) Demencia tipo Alzheimer; prescribir Memantina en bolo
E) Trastorno adaptativo; indicar reposo y contención mecánica sin medicamentos

PREGUNTA 64 1.09.2.001

64. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de psicofármacos parenterales está ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADA en el servicio de urgencias por asociarse a un alto riesgo de colapso cardiorrespiratorio fatal e hipotensión severa refractaria?

A) Haloperidol IM asociado a Lorazepam IM
B) Olanzapina IM coadministrada de forma simultánea con Lorazepam IM
C) Haloperidol IM asociado a Biperideno IM
D) Clorpromazina VO asociada a Diazepam VO
E) Risperidona VO asociada a Clonazepam VO

PREGUNTA 65 1.09.2.001

65. Respecto a la contención física mecánica de cuatro extremidades en un paciente con agitación psicomotora violenta que no respondió a contención verbal ni farmacológica, ¿cuál es una exigencia legal y clínica obligatoria según la Ley N° 21.331 de salud mental en Chile?

A) La indicación puede ser verbal y no requiere ser registrada en la ficha clínica
B) Debe existir una indicación médica explícita registrada por escrito en la ficha clínica, detallando la justificación, y se debe supervisar y registrar la condición del paciente cada 15 a 30 minutos
C) El paciente debe ser dejado en posición prono (boca abajo) para evitar que muerda al personal
D) La sujeción mecánica debe mantenerse fija por un período mínimo obligatorio de 24 horas ininterrumpidas
E) Las sujeciones deben atarse directamente a las barandas laterales móviles de la camilla

PREGUNTA 66 5.01.2.002

66. Un paciente de 39 años es detenido, porque estaba haciendo disturbios en la vía pública. Es llevado para constatar lesiones y, al examen no coopera y se muestra angustiado y agitado, con agresión verbal hacia el personal de salud, sin llegar a la agresión física. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar haloperidol 5 mg intramuscular
B) Risperidona 1 mg vía oral
C) Diazepam 5 mg intramucular
D) Contención verbal
E) Contención física

PREGUNTA 67 1.09.1.001

67. Un hombre de 52 años en situación de calle con antecedente de alcoholismo crónico severo y desnutrición extrema es llevado a urgencias por compromiso de conciencia progresivo. Al examen físico destaca sopor profundo, nistagmo bilateral horizontal y ataxia de tronco que le impide la bipedestación. La glicemia capilar informa 48 mg/dL. ¿Cuál es la secuencia farmacológica obligatoria que debe administrarse de inmediato?

A) Administrar 4 ampollas de suero glucosado al 30% EV en bolo rápido y luego evaluar vitaminas
B) Administrar Tiamina 100 mg endovenosa o intramuscular previo o simultáneo a la infusión de suero glucosado
C) Administrar Fenitoína 1 g en infusión endovenosa rápida
D) Administrar Naloxona 0.4 mg EV y Flumazenil 0.5 mg EV directo
E) Administrar Insulina cristalina 10 UI subcutáneas

PREGUNTA 68 1.09.1.001

68. Un hombre de 45 años con antecedente de cirrosis hepática Child-Pugh B por alcoholismo crónico ingresa a urgencias por un síndrome de abstinencia alcohólica moderado a severo (CIWA-Ar de 18 puntos) con temblor marcado, náuseas, diaforesis y ansiedad extrema tras 24 horas del cese de ingesta. ¿Cuál es la benzodiacepina de elección para tratar la abstinencia en este paciente con daño hepático demostrado?

A) Diazepam
B) Lorazepam
C) Clordiazepóxido
D) Alprazolam
E) Midazolam

PREGUNTA 69 1.09.1.001

69. Un paciente alcohólico de 42 años consulta en urgencias a las 18 horas de su último trago refiriendo escuchar voces de personas desconocidas que murmuran amenazas a través de la pared del baño. En el examen mental se constata vigil, perfectamente orientado en tiempo y espacio (sabe la fecha exacta y dónde está), con atención preservada y juicio parcialmente conservado, reconociendo que las voces podrían deberse a haber dejado el trago. El examen neurológico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Delirium Tremens
B) Alucinosis Alcohólica
C) Esquizofrenia paranoide de inicio tardío
D) Encefalopatía hepática grado IV
E) Demencia de Korsakoff

PREGUNTA 70 5.01.1.012

70. Un paciente de 70 años, con antecedente de daño hepá8co crónico y consumo de alcohol ac8vo, consulta porque quiere dejar de beber. Consume 3 litros de cerveza al día y comenta que hace un año intentó bajar el consumo a 1 litro al día, sin embargo, presentó agitación, angus8a y la visualización de insectos que él no sabía que no eran reales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar el cese inmediato del consumo de alcohol
B) Iniciar disulfiram
C) Hospitalizar para desintoxicación
D) Indicar lorazepam
E) Derivar para psicoterapia cogni2vo-conductual

PREGUNTA 71 5.01.1.014

71. Un paciente de 56 años es encontrado inconsciente en la vía pública, con hálito alcohólico, con varios golpes. Se hospitaliza para manejo de sus lesiones, sin embargo, a las 48 horas presenta gran agitación, diciendo que lo tienen encerrado en la cárcel y no lo dejan escapar. Se observa desorientado, tembloroso y no coopera con el interrogatorio. ¿Cuál es el fármaco de elección para su manejo?

A) Tiamina
B) Haloperidol
C) Lorazepam
D) Clorpromazina
E) Risperidona

PREGUNTA 72 5.01.1.025

72. [ATENCIÓN PRIMARIA: Retardo mental · 5.01.1.025] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Retardo mental. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

BLOQUE 5 ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

PREGUNTA 73 5.01.1.027

73. [ATENCIÓN PRIMARIA: Encopresis · 5.01.1.027] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Encopresis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 74 5.01.1.011

74. Una paciente de 35 años es traída al servicio de urgencia debido a que, luego del consumo de alcohol en una fiesta, presentó una ac8tud agresiva peleando con otros invitados, a quienes arrojó vasos de vidrio, por lo que fue re8rada del lugar. Refiere que consume alcohol de manera esporádica, habitualmente solo durante los fines de semana, y que lo hace como una forma de distenderse de su alta carga laboral. En una oportunidad fue detenida por manejar en estado de ebriedad, sin embargo, ella no considera que ello sea un problema. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar disulfiram vía oral
B) Indicar benzodiacepinas vía oral
C) Iniciar bupropión vía oral
D) Realizar entrevista mo2vacional
E) Derivar para psicoterapia cogni2vo-conductual

PREGUNTA 75 5.01.1.011

75. Un hombre de 24 años consulta en urgencias por dolor precordial opresivo de 30 minutos de evolución tras haber consumido cocaína. Al ingreso destaca muy angustiado, sudoroso, con midriasis bilateral reactiva, PA 195/110 mmHg y FC 130 lpm. El ECG muestra taquicardia sinusal e infradesnivel del ST de 1.5 mm en cara anterolateral. ¿Cuál de los siguientes fármacos está FORMALMENTE CONTRAINDICADO en este paciente?

A) Diazepam endovenoso
B) Nitroglicerina sublingual
C) Propranolol endovenoso
D) Ácido Acetilsalicílico oral
E) Lorazepam endovenoso

PREGUNTA 76 5.01.1.011

76. Una mujer de 65 años con antecedente de insomnio crónico en tratamiento regular con Clonazepam 2 mg diario desde hace 10 años es traída a urgencias en sopor profundo tras ingerir accidentalmente una dosis triple de su medicación junto con una copa de vino. Sus signos vitales son estables (PA 115/70 mmHg, FC 72 lpm, SatO2 97% ambiental) y no presenta compromiso hemodinámico ni apnea. El médico de turno evalúa administrar Flumazenil endovenoso para revertir el sopor. ¿Por qué está desaconsejado o contraindicado el uso de Flumazenil en este escenario?

A) Porque el flumazenil carece de acción sobre los receptores de clonazepam
B) Porque en usuarios crónicos de benzodiacepinas el flumazenil precipita un síndrome de abstinencia agudo severo con alto riesgo de status epiléptico refractario mortal
C) Porque el flumazenil produce hiperpotasemia fulminante
D) Porque está reservado exclusivamente para sobredosis de morfina y opioides
E) Porque aumenta la presión intraocular de forma irreversible

PREGUNTA 77 5.01.2.003

77. Un hombre encuentra a su pareja en su casa desorientada y con una ac8tud agresiva y agitada, por lo que la lleva al servicio de urgencia. Al examen Fsico presenta sudoración profusa y sus signos vitales muestran presión arterial 170/110 mmHg, frecuencia cardíaca 160 por minuto y temperatura 38,1 °C. En el examen neurológico se aprecia desorientada en 8empo y espacio, con agitación psicomotora y pupilas midriá8cas isocóricas. ¿Qué sustancia ingirió con mayor probabilidad?

A) Barbitúricos
B) Canabinoides
C) Anfetaminas
D) Órganofosforados
E) Opiáceos

PREGUNTA 78 1.09.1.001

78. Un hombre de 34 años, soltero, informático que realiza teletrabajo en horario nocturno, es derivado por salud laboral. Vive completamente solo, no tiene amigos y refiere: "No me interesa compartir con nadie, me siento mucho más cómodo así; los elogios o reproches de mi jefe me dan exactamente lo mismo". No presenta ideas delirantes, alucinaciones ni síntomas afectivos. Su discurso es coherente pero con notable frialdad emocional. ¿Cuál es el diagnóstico de personalidad más probable?

A) Trastorno de personalidad por evitación
B) Trastorno de personalidad esquizoide
C) Trastorno de personalidad esquizotípico
D) Trastorno de personalidad paranoide
E) Fobia social grave

PREGUNTA 79 1.09.1.001

79. Una joven de 20 años acude al servicio de urgencias traída por su madre tras cortarse los antebrazos superficialmente con un bisturí escolar. La madre refiere que la paciente pasa de la risa al llanto en cuestión de horas, gasta dinero impulsivamente, tiene un miedo pánico a quedarse sola y con frecuencia acusa a sus familiares de "no quererla". ¿Cuál es el abordaje psicoterapéutico que cuenta con mayor respaldo de evidencia científica para este cuadro?

A) Terapia Electroconvulsiva bilateral
B) Terapia Dialéctico-Conductual (DBT)
C) Psicoanálisis clásico exclusivo
D) Hipnosis clínica regresiva
E) Terapia de relajación pasiva exclusiva

PREGUNTA 80 5.01.1.016

80. Una paciente de 32 años, madre de 4 hijos, de distintos padres, de los cuales no se hace cargo, tiene relaciones inestables y problemas frecuentes con sus compañeros de trabajo. Pelea frecuentemente con su familia y como antecedente, ha tenido varios episodios de autoagresión e intentos suicidas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esquizofrenia
B) Trastorno límite de la personalidad
C) Trastorno bipolar
D) Trastorno delirante
E) Trastorno depresivo mayor

PREGUNTA 81 5.01.1.016

81. Una paciente tiene relaciones interpersonales intensas e inestables y problemas frecuentes con las demás personas. Presenta antecedentes de dos intoxicaciones medicamentosas y autoagresiónes. Además estuvo en tratamiento por bulimia hace un año. Tiene un sentimiento crónico de inutilidad y vacío. Además es impulsiva en el consumo de alcohol y compras. ¿A qué trastorno de la personalidad corresponde el cuadro?

A) Histriónico
B) Limítrofe
C) Narcisista
D) Antisocial
E) Dependiente

PREGUNTA 82 5.01.1.016

82. Un paciente de 30 años, consulta debido a que se siente deprimido. Es padre de tres hijos con tres mujeres diferentes, tiene antecedentes de múltiples fracasos académicos y laborales y se encuentra sin actividad laboral en la actualidad. Al interrogatorio, consume alcohol con cierta frecuencia, bebiendo 3 o 4 días a la semana en cantidad que él considera moderada, aunque reconoce que se emborracha los fines de semana. Además, con frecuencia se involucra en actividades riesgosas y presenta una autoimagen negativa. En el pasado, ha tenido ideación suicida con autoagresión, aunque no la tiene en la actualidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esquizofrenia
B) Trastorno de conducta
C) Trastorno de personalidad limítrofe
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno adaptativo

PREGUNTA 83 5.01.1.016

83. Una paciente de 28 años tiene problemas frecuentes con sus familiares, con quienes suele pelearse y distanciarse, pero luego de algunos meses retoma la relación, como si nada hubiese pasado. Además tiene antecedente de haber ingerido medicamentos con intención suicida y haberse autoagredido. Además ha cambiado varias veces de trabajo, ya que le cuesta atenerse a las normas, lo que le ha generado problemas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno adaptativo
B) Trastorno de personalidad limítrofe
C) Trastorno bipolar
D) Distimia
E) Depresión mayor

PREGUNTA 84 5.01.1.016

84. Una paciente que desde niña es muy tímida, tiene dificultades para relacionarse con otras peronsonas, por temor al rechazo. No ha tenido pareja y evita las situaciones en que hay muchas personas. Le gustaría mejorar su situación y desarrollar su autoestima. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno de personalidad evitativo
B) Trastorno de personalidad dependiente
C) Fobia social
D) Agorafobia
E) Trastorno de ansiedad generalizada

PREGUNTA 85 5.01.1.016

85. **Una mujer de 23 años quien, desde la niñez es extremadamente introvertida y con baja autoestima por lo que se le es difícil conseguir amigos, por miedo a que pensarán de ella, esto la hace infeliz. En cambio, con su familia es muy cariñosa. El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno evitativo de la personalidad
B) Síndrome de Asperger
C) Depresión mayor
D) Distimia
E) Fobia social

PREGUNTA 86 4.01.1.001

86. **Un niño de 8 años es traído a consulta médica porque su profesora señala que se para constantemente de su asiento en clases, habla sin parar, interrumpe a sus compañeros y no termina las guías escolares por distraerse con cualquier estímulo. Los padres relatan que en la casa el niño presenta la misma conducta desde los 5 años: no logra mantenerse sentado a la mesa, pierde constantemente los lápices y cuadernos, y le cuesta seguir instrucciones de más de un paso. Su coeficiente intelectual y examen neurológico son normales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y el fármaco de primera línea?**

A) Trastorno del espectro autista; iniciar Risperidona
B) Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH); tratamiento farmacológico de primera línea con Metilfenidato asociado a intervenciones psicopedagógicas
C) Trastorno bipolar maníaco precoz; iniciar Carbonato de Litio
D) Trastorno oposicionista desafiante puro; internación en centro psiquiátrico
E) Depresión infantil enmascarada; indicar Sertralina

PREGUNTA 87 4.01.1.001

87. **Una adolescente de 16 años consulta traída por su colegio debido a emaciación progresiva. Al examen físico destaca con IMC de 13.5 kg/m², hipotermia de 35.0 °C, presión arterial de 75/45 mmHg y frecuencia cardíaca de 34 lpm en reposo. Se constata lanugo en espalda y abdomen escafoide. La paciente rechaza tener problemas y afirma que solo desea "bajar un par de kilos más". ¿Cuál es la conducta médica inmediata e ineludible?**

A) Indicar dieta hipercalórica fraccionada y citar a control en un mes en policlínico
B) Hospitalización médica inmediata en unidad de cuidados intensivos/intermedios para monitorización cardíaca y realimentación lenta controlada
C) Prescribir Fluoxetina 60 mg al día por vía oral y dar el alta a su domicilio
D) Derivar a psicoterapia psicoanalítica ambulatoria semanal
E) Indicar Metilfenidato matinal para mejorar su motivación de alimentarse

PREGUNTA 88 5.01.1.018

88. **Una paciente de 17 años es traída por su padre, quien se muestra muy preocupado porque la considera muy delgada y siente que come muy poco. Relata que solo come una fracción del plato que se sirve en su casa y que deja gran parte de la comida que se le envía al colegio. La paciente comenta que la mayoría de sus compañeras son igualmente delgadas y no considera que tenga un problema, más allá de mostrarse molesta por la insistencia de su padre en consultar. Su IMC es de 16 kg/m². ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Trastorno obsesivo de la personalidad
B) Bulimia nervosa
C) Anorexia nervosa
D) Dismorfofobia
E) Sana

PREGUNTA 89 5.01.1.030

89. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Trastorno conducta oposicionista desafiante · 5.01.1.030] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Trastorno conducta oposicionista desafiante. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 90 5.01.1.031

90. **Adolescente de 14 años que presenta ausencias repetidas al colegio, peleas con compañeros, robos dentro del hogar y consumo de alcohol desde los 12 años. Los padres refieren que "no respeta ninguna norma". ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Discapacidad intelectual
B) TDAH
C) Trastorno de conducta
D) Trastorno del espectro autista
E) Fobia social

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 Respuesta: A

Dependencia de otras drogas

5.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La base del tratamiento de todas las adicciones es la TCC. Además, en fumadores de menos de 15 cigarrillos al día suele ser la única intervención necesaria, ya que no suelen tener dependencia física a la nicotina. Sobre esa cantidad, a la TCC se le suele agregar sustitución con nicotina (si muchos síntomas de abstinencia) y bupropión o vareniclina (si mucho deseo de fumar).

PREGUNTA 2 Respuesta: C

Intento de suicidio en niños y adolescentes

5.01.1.029 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 87). Evalúa el manejo clínico de Intento de suicidio en niños y adolescentes según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 3 Respuesta: B

Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

4.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La paciente presenta un episodio depresivo mayor moderadamente grave cubierto por el GES N° 21. La indicación correcta de primera línea es un ISRS como Sertralina 50 mg/día por la mañana, acompañado de psicoterapia, educación al paciente sobre el período de latencia terapéutica (2-4 semanas) y control en 2 semanas para supervisar adherencia y tolerancia. El distractor A es erróneo porque las benzodiacepinas no tienen acción antidepresiva y generan dependencia. El distractor C es incorrecto porque no hay ideación suicida activa ni síntomas psicóticos que justifiquen hospitalización o TEC. El distractor D posterga injustificadamente el tratamiento normado. El distractor E usa dosis tóxicas de tricíclicos y antipsicóticos innecesarios. Perla de examen: Todo inicio de ISRS en APS debe acompañarse de educación sobre la latencia de respuesta para evitar el abandono prematuro por parte del paciente.

PREGUNTA 4 Respuesta: D

Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

5.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tiene un trastorno adaptativo clásico de tipo ansioso (gatillante claro y síntomas ansiosos). Si bien tiene síntomas somáticos (cefalea tensional) no es un trastorno de somatización (múltiples síntomas de todo tipo).

PREGUNTA 5 Respuesta: B

Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

5.01.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Depresión: La depresión se trata preferentemente con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) como la sertralina. La depresión atípica, por otro lado, presenta síntomas como aumento de peso e hipersomnia y tradicionalmente se trataba con inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) como la fenelzina, pero, en la actualidad, los ISRS también se recomiendan como tratamiento de primera línea para la depresión atípica. En este caso es típica, al haber insomnio, en lugar de hipersomnia.

PREGUNTA 6 Respuesta: B

Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

5.01.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tratamiento de la Depresión: El tratamiento de elección para un episodio depresivo mayor unipolar son los antidepresivos ISRS, especialmente si el paciente ya ha respondido a este tipo de medicamento. Si no hay respuesta después de 4 semanas, se recomienda cambiar a un antidepresivo dual como venlafaxina o duloxetina.

PREGUNTA 7 **Respuesta: A**

5.01.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Trastornos neurocognitivos" (5.01.1.015), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 8 **Respuesta: B**

5.01.1.020 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

Es un trastorno conversivo típico: síntomas neurológicos de inicio rápido y sin una causa orgánica que los explique. En estricto rigor sí es un trastorno somatomorfo (D), ya que los trastornos conversivos son un tipo de trastornos somatomorfos, pero la B es más específica.

PREGUNTA 9 **Respuesta: E**

5.01.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

Es una amnesia disociativa clásica.

PREGUNTA 10 **Respuesta: B**

5.01.1.022 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

Tiene un trastorno facticio clásico, del tipo Múnchausen, ya que se autoprovoca síntomas (no solo los finge). No tiene ganancias económicas (así que no es simulación, sino facticio, cuya ganancia es afectiva, aunque no se muestre en la pregunta).

PREGUNTA 11 **Respuesta: D**

5.01.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

Es un TEA clásico del adulto, con rigidez cognitiva, intereses restringidos, alteraciones sociales, estereotipias más escasa autorregulación, seguramente por estar mal manejado.

PREGUNTA 12 **Respuesta: A**

5.01.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Trastorno específico del aprendizaje escolar" (5.01.1.024), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 13 **Respuesta: D**

5.01.1.028 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

Es un TDAH clásico, de alta capacidad (logró ser ingeniera). Se maneja con técnicas de trabajo y, en algunos casos, fármacos estimulantes como el meGlfenidato y anfetaminas (ej. lisdexanfetamina).

PREGUNTA 14 **Respuesta: A**

5.01.1.032 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Trastorno somatización en niños" (5.01.1.032), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 15 **Respuesta: A**

5.01.1.033 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Trastornos ansiosos en niños" (5.01.1.033), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 16 **Respuesta: C**

5.01.1.034 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

Depresión en Adolescentes: El cuadro clínico corresponde a una depresión o episodio depresivo mayor. La distimia se diagnostica en adolescentes tras un año de ánimo bajo y disforia sin cumplir criterios de depresión. En este caso, sí hay criterios de depresión porque se afecta el peso, el sueño, el rendimiento escolar y la vida social.

PREGUNTA 17 **Respuesta: A**

5.01.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Conducta suicida" como urgencia clínica (5.01.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 18 **Respuesta: A**

5.01.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES

Episodios depresivos previos + episodio maníaco actual (grandiosidad, insomnio, gastos impulsivos, euforia) = trastorno bipolar tipo I. Un episodio maníaco es suficiente para el diagnóstico.

BLOQUE 2 TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 19 **Respuesta: B** **Disfunción sexual**

5.01.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Dispareunia Superficial: La dispareunia superficial, también conocida como vaginismo o síndrome de dolor genitopélvico penetración, se caracteriza por la contracción involuntaria de los músculos vaginales, causando dolor durante la penetración. Es importante diferenciarla del trastorno orgásmico femenino (ausencia de orgasmo) y el trastorno del deseo sexual hipoactivo (disminución del deseo sexual), que no presentan dolor.

PREGUNTA 20 **Respuesta: D**

5.01.1.035 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Consumo perjudicial de drogas en niños y adolescentes

Pregunta difícil.

PREGUNTA 21 **Respuesta: B**

1.11.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo

El paciente presenta una reacción emocional desadaptativa temporal ante un estresor biográfico claro (ruptura amorosa hace 6 semanas). Los síntomas llevan 4 semanas (< 3 meses de inicio), causan malestar pero no cumplen los 5 criterios exigidos para un Episodio Depresivo Mayor (mantiene apetito, reactividad afectiva y capacidad de actividad física). Corresponde a un Trastorno Adaptativo. El manejo correcto en atención primaria es la psicoterapia breve y consejería para elaboración del duelo vincular, sin indicación de antidepresivos (A) ni benzodiacepinas crónicas (C). La distimia (D) requiere al menos 2 años de evolución continua. Perla de examen: En trastorno adaptativo reactivo a un estresor identificable, la psicoterapia es el tratamiento angular y no se indican antidepresivos de entrada.

PREGUNTA 22 **Respuesta: B**

1.11.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo

El cuadro de ánimo depresivo crónico, baja energía, baja autoestima y anhedonia leve a moderada de curso continuo durante más de 10 años, sin períodos asintomáticos superiores a 2 meses, cumple con precisión los criterios diagnósticos del Trastorno Depresivo Persistente (Distimia). A diferencia de la creencia tradicional de que la distimia solo responde a psicoterapia, la evidencia actual demuestra que el tratamiento óptimo es la combinación de un ISRS (como Sertralina o Escitalopram) a dosis plenas durante períodos prolongados asociado a psicoterapia cognitivo-conductual estructurada. El trastorno adaptativo (A) requiere un estresor reciente (< 3 meses) y dura menos de 6 meses. La personalidad esquizoide (C) no presenta ánimo depresivo ni sufrimiento egodistónico. Perla de examen: La distimia exige al menos 2 años de síntomas continuos en adultos y se beneficia significativamente de la combinación de ISRS y psicoterapia.

PREGUNTA 23 **Respuesta: B**

1.03.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS

La paciente presenta un Trastorno de Pánico con agorafobia incipiente. El tratamiento farmacológico de elección y primera línea a largo plazo son los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS) como Sertralina, iniciando a dosis bajas (25 mg/día) para minimizar la exacerbación inicial de ansiedad, asociada a Terapia Cognitivo-Conductual (TCC). Las benzodiacepinas se utilizan únicamente como puente transitorio (primeras 2-4 semanas) mientras se instala el efecto terapéutico del ISRS. El distractor A comete el error grave de perpetuar benzodiacepinas en monoterapia, lo que genera adicción y rebote. El distractor C usa betabloqueadores que controlan la taquicardia periférica pero no tratan el trastorno de pánico central. El distractor D usa antipsicóticos típicos innecesarios. Perla de examen: En trastorno de pánico, los ISRS a titulación lenta son la base del tratamiento definitivo, reservando las benzodiacepinas como rescate inicial acotado.

PREGUNTA 24 **Respuesta: B**

1.03.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS

El manejo de la crisis de angustia aguda en el servicio de urgencias se basa en medidas no farmacológicas iniciales: ubicar al paciente en un entorno tranquilo, brindar contención verbal asegurando que no se encuentra en peligro vital y reeducar el patrón respiratorio para frenar la hiperventilación diafragmática. Si la ansiedad persiste elevada, se indica una benzodiacepina de acción rápida y absorción sublingual u oral como Clonazepam 0.5-1 mg o Lorazepam 1 mg. La adenosina (A) es para taquicardias paroxísticas supraventriculares, no para taquicardia sinusal por pánico. La morfina (D) está contraindicada. Respirar en bolsa plástica cerrada (E) está obsoleto y proscrito porque puede causar hipoxia severa y arritmias. Perla de examen: La contención verbal empática y las benzodiacepinas orales/sublinguales constituyen el pilar de rescate en la crisis de pánico aguda.

PREGUNTA 25 **Respuesta: B**

1.03.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS

Al iniciar un ISRS en pacientes con trastorno de pánico, el incremento agudo de serotonina en la corteza y amígdala estimula de forma precoz receptores postsinápticos 5-HT2A y 5-HT2C antes de que ocurra la desensibilización de autorreceptores, lo que desencadena un aumento paradójico transitorio de ansiedad, temblor y taquicardia en los primeros 5 a 10 días. La conducta correcta es anticipar este fenómeno, educar al paciente para que no abandone la terapia, disminuir la dosis a la mitad temporalmente (10 mg de fluoxetina o 25 mg de sertralina) y usar una benzodiacepina a dosis baja como puente sintomático durante las primeras semanas. Duplicar la dosis (E) exacerbaría el cuadro. Perla de examen: En trastorno de pánico, los ISRS deben iniciarse siempre a mitad de dosis para evitar el síndrome de aumento paradójico de ansiedad.

PREGUNTA 26 **Respuesta: B**

1.03.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS

La paciente presenta Agorafobia, definida por el miedo intenso y evitación de situaciones donde escapar pueda ser difícil o la ayuda inaccesible en caso de desarrollar síntomas tipo pánico (transporte, multitudes, salir sola de casa). La psicoterapia con mayor nivel de evidencia científica (Nivel IA) para la agorafobia es la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), específicamente mediante desensibilización sistemática con técnicas de exposición en vivo gradual a las situaciones temidas y exposición interoceptiva a las sensaciones corporales. El distractor A confunde la evitación fóbica con delirios. El distractor D confunde agorafobia con fobia social (en la fobia social el miedo es al escrutinio y juicio negativo de los demás, no a quedar atrapado o morir). Perla de examen: La TCC con técnicas de exposición en vivo e interoceptiva es la psicoterapia de elección en agorafobia.

PREGUNTA 27 **Respuesta: A**

5.01.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS

Tiene un trastorno de pánico o trastorno de ansiedad o de angustia clásico: crisis de pánico recurrentes e inexplicadas. Que ya no salga de su casa sugiere que, además, tiene agorafobia, pero predomina el diagnóstico de TP.

PREGUNTA 28 **Respuesta: B**

5.01.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS

Tiene crisis de pánico recurrentes, por lo que es un trastorno de angustia o trastorno de pánico. El miedo a salir de su casa probablemente sea porque es "con agorafobia". El tratamiento de los trastornos ansiosos suele ser con antidepresivos IRS. Las benzodiacepinas sirven como tratamiento sintomático, pero el IRS es el tratamiento principal.

PREGUNTA 29 **Respuesta: E**

5.01.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS

Tuvo una crisis de pánico y, por recurrir, ahora tiene un trastorno de pánico (o de angustia o de ansiedad), que se trata con IRS (se pueden agregar BDZ, ejemplo alprazolam c/8 horas al inicio y luego SOS, pero solo como tratamiento sintomático). No confundir con trastorno de ansiedad generalizada, aunque el tratamiento es el mismo.

PREGUNTA 30 **Respuesta: B**

1.09.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social

El cuadro cumple con los criterios diagnósticos DSM-5 para Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG): preocupación excesiva e incontrolable sobre múltiples ámbitos de la vida diaria presente durante más de 6 meses (8 meses en el caso), asociada a tensión muscular, irritabilidad e insomnio. El tratamiento de elección y primera línea avalado por la evidencia son los ISRS (Escitalopram 10-20 mg/día o Sertralina 50-100 mg/día) o IRSN (Venlafaxina) combinados con Terapia Cognitivo-Conductual (TCC). Las benzodiacepinas a demanda (A) no tratan la patología de base y conllevan riesgo adictivo. No hay síntomas psicóticos (D). El Propranolol (E) no es el tratamiento de mantenimiento del TAG. Perla de examen: El criterio temporal del TAG es de al menos 6 meses y su tratamiento de 1.ª línea son los ISRS.

PREGUNTA 31 **Respuesta: B**

1.09.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social

El cuadro corresponde a un Trastorno de Ansiedad Social (Fobia Social) en su subtipo circunscrito o de actuación en público (pánico escénico). Al no existir un trastorno de ansiedad generalizado en la vida diaria, no está indicado el uso de antidepresivos continuos a largo plazo. La indicación farmacológica de elección y alta rentabilidad para este escenario en el EUNACOM es un betabloqueador no cardioselectivo: Propranolol 10 a 40 mg vía oral tomado 30 a 60 minutos antes de la exposición. El fármaco bloquea los receptores adrenérgicos periféricos suprimiendo el temblor, la taquicardia y el rubor sin alterar la claridad cognitiva. Perla de examen: En fobia social de actuación circunscrita a hablar en público, el Propranolol administrado 1 hora antes es el tratamiento de rescate de elección.

PREGUNTA 32 **Respuesta: A**

5.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social

Fobia social / trastorno de ansiedad social: el tratamiento farmacológico de primera línea son los ISRS (sertralina, escitalopram, paroxetina). Se combinan con TCC. El propranolol es para situaciones puntuales.

PREGUNTA 33 **Respuesta: E**

5.01.1.036 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social

Tiene distinas preocupaciones, de distintos tipos, por lo que es un TAG clásico.

PREGUNTA 34 **Respuesta: B**

1.13.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS

El paciente presenta un Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) con obsesiones de duda/daño y compulsiones de comprobación. El cuadro es nítidamente egodistónico (el paciente reconoce que es absurdo e intenta no hacerlo, pero la angustia lo doblega), lo que excluye el trastorno de personalidad anancástico/TPOC (A). La psicoterapia con mayor grado de recomendación y evidencia científica en TOC es la Terapia Cognitivo-Conductual con Exposición con Prevención de Respuesta (EPR), en la cual se expone al paciente al estímulo que gatilla la obsesión impidiendo la ejecución del ritual de comprobación. No hay psicosis (C y D). Perla de examen: En el TOC la clínica es egodistónica y la psicoterapia obligada es la Exposición con Prevención de Respuesta.

PREGUNTA 35 **Respuesta: B**

1.13.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS

Una de las particularidades farmacológicas fundamentales del TOC en el EUNACOM es que la respuesta terapéutica exige dosis significativamente mayores de ISRS que las empleadas en la depresión mayor (ej. Fluoxetina 60-80 mg/día, Sertralina 200 mg/día) y un período de latencia sustancialmente más prolongado (8 a 12 semanas para alcanzar la meseta terapéutica). Evaluar la respuesta a las 4 semanas con dosis baja (20 mg de fluoxetina) es un error metodológico. La conducta correcta es educar al paciente, titular progresivamente la dosis hacia el rango máximo tolerado y esperar el tiempo normado antes de rotar de fármaco. Perla de examen: En el TOC los ISRS requieren dosis altas y un período de evaluación mínimo de 8 a 12 semanas.

PREGUNTA 36 **Respuesta: E**

5.01.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS

TOC de libro

BLOQUE 3 TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TOC & TRAUMA · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: A**

5.01.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Sexualidad humana y sus alteraciones

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Sexualidad humana y sus alteraciones" (5.01.1.019), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 38 **Respuesta: B**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES

El paciente cumple criterios DSM-5 para Esquizofrenia: síntomas positivos (delirios de persecución, alucinaciones auditivas comentadoras), síntomas negativos (aplanamiento afectivo, abulia) y disfunción sociolaboral grave de más de 6 meses de duración en un adulto joven con tóxicos negativos. En Chile, este cuadro constituye un Primer Episodio de Esquizofrenia cubierto por la Garantía GES N° 34, que garantiza confirmación diagnóstica por psiquiatra en ≤ 20 días y tratamiento integral en ≤ 24 horas desde la confirmación. La conducta correcta es notificar el caso GES, iniciar un antipsicótico atípico de primera línea (ej. Risperidona u Olanzapina) y derivar a nivel secundario. El trastorno psicótico breve (D) dura menos de un mes. Perla de examen: En Chile, todo primer episodio de esquizofrenia en mayores de 15 años debe notificarse e ingresar por GES N° 34.

PREGUNTA 39 **Respuesta: B**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES

El cuadro corresponde a una Distonía Aguda, reacción adversa extrapiramidal precoz (habitualmente en las primeras 24 a 48 horas tras iniciar o aumentar la dosis de un antipsicótico de alta potencia como Haloperidol). Se produce por un bloqueo dopaminérgico agudo que genera un predominio colinérgico relativo en los ganglios basales, manifestándose como contracciones musculares tónicas dolorosas e involuntarias (crisis oculógiras, tortícolis espasmódica, trismus). El tratamiento de rescate inmediato y específico es un anticolinérgico de acción central: Biperideno 5 mg IM o EV lento, con resolución de los síntomas en 10 a 20 minutos. El SNM (A) cursa con hipertermia grave, rigidez en tubo de plomo y disautonomía. Perla de examen: La distonía aguda por antipsicóticos es precoz y se trata de urgencia con Biperideno parenteral.

PREGUNTA 40 **Respuesta: B**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES

La Olanzapina (junto con la Clozapina) es el antipsicótico con mayor riesgo de síndrome metabólico, provocando ganancia ponderal masiva, hipertrigliceridemia, resistencia a la insulina y debut de Diabetes Mellitus tipo 2. La conducta médica integral ante este hallazgo consiste en: 1) Diagnosticar y tratar la diabetes mellitus y dislipidemia con cambios en el estilo de vida y metformina; y 2) Planificar la rotación gradual del antipsicótico hacia un agente con perfil metabólico neutro, siendo Aripiprazol o Ziprasidona las opciones de elección. Suspender el antipsicótico sin sustituto (D) gatillaría una recaída psicótica grave. Perla de examen: Olanzapina tiene el mayor riesgo de ganancia ponderal y diabetes mellitus entre los atípicos; Aripiprazol es neutro metabólicamente.

PREGUNTA 41 **Respuesta: B**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES

En un paciente que ha presentado un primer episodio psicótico esquizofrénico y alcanza la remisión sintomática, las guías internacionales y la guía GES N° 34 recomiendan mantener el tratamiento antipsicótico de forma continua y a dosis terapéutica durante un período mínimo de 1 a 2 años. La suspensión precoz del antipsicótico antes del año se asocia a una tasa de recaída psicótica superior al 70-80% en los siguientes 12 meses, con el agravante de que cada recaída produce deterioro neurocognitivo residual y mayor riesgo de refractariedad. En pacientes con dos o más episodios psicóticos previos, la mantención se prolonga a 5 años o de por vida. Perla de examen: En un primer episodio de esquizofrenia con remisión completa, la duración mínima del tratamiento de mantenimiento con antipsicóticos es de 1 a 2 años.

PREGUNTA 42 **Respuesta: D**

5.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES

La risa sin motivo orienta a Hebefrenia. El cuadro clínico es sugerente de EQZ.

PREGUNTA 43 **Respuesta: B**

5.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES

Tiene un TDC clásico, con un delirio sistematizado y afectación únicamente en esa área. Si bien es relativamente joven, no tiene alucinaciones ni síntomas negativos o primarios de esquizofrenia.

PREGUNTA 44 **Respuesta: B**

5.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES

Es una EQZ clásica.

PREGUNTA 45 **Respuesta: B**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma

El paciente cumple rigurosamente con los criterios de Esquizofrenia Refractaria (falla terapéutica demostrada a dos antipsicóticos distintos en dosis plenas durante al menos 6 semanas cada uno, incluyendo un antipsicótico atípico como la risperidona). En este escenario clínico, el único fármaco que ha demostrado eficacia estadísticamente significativa y superior es la Clozapina. Dado que su hemograma basal es normal (leucocitos > 3.500 y RAN > 2.000), la indicación correcta es iniciar Clozapina bajo el protocolo estricto de farmacovigilancia hematológica obligatoria (hemograma semanal los primeros 6 meses). Los demás distractores corresponden a errores diagnósticos graves. Perla de examen: En esquizofrenia refractaria tras falla de 2 antipsicóticos plenos, la Clozapina es el tratamiento de elección.

PREGUNTA 46 **Respuesta: B**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma

El paciente presenta una agranulocitosis inducida por Clozapina (RAN < 1.000/mm³, en este caso 790/mm³). Esta es una complicación potencialmente mortal por sepsis neutropénica fulminante. La conducta médica normada e innegociable es: 1) Suspensión inmediata y definitiva de la Clozapina; 2) Hospitalización en aislamiento protector; 3) Evaluación hematológica para eventual uso de Filgrastim (G-CSF); y 4) Registrar la contraindicación absoluta y permanente de reexposición a Clozapina de por vida. Reducir la dosis (A) o esperar (E) expone al paciente a muerte inminente por shock séptico. El biperideno (D) no tiene ninguna acción sobre la médula ósea. Perla de examen: Con Clozapina, un RAN < 1.000/mm³ exige la suspensión inmediata y definitiva del fármaco sin posibilidad de reexposición de por vida.

PREGUNTA 47 **Respuesta: B**

1.13.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo

El cuadro se inicia tras un evento traumático de amenaza vital hace 3 semanas y los síntomas llevan 10 días de evolución. Dado que la duración del cuadro es menor a 1 mes (menos de 30 días desde el evento), la clasificación nosológica precisa según el DSM-5 es Trastorno de Estrés Agudo. Si los síntomas de intrusión, evitación e hiperalerta persistieran más allá del mes de evolución, el diagnóstico se reclasificaría como Trastorno de Estrés Postraumático (A). No existen elementos psicóticos (C) ni crisis paroxísticas espontáneas desvinculadas del trauma (D). Perla de examen: En patología postraumática, la frontera temporal es exactamente 1 mes: menos de 30 días es Estrés Agudo, más de 30 días es TEPT.

PREGUNTA 48 **Respuesta: A**

1.13.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo

La Prazosina es un antagonista selectivo de los receptores alfa-1 adrenérgicos que cruza la barrera hematoencefálica y disminuye la hiperactividad noradrenérgica central durante el sueño REM. Cuenta con sólida evidencia clínica para la reducción específica de las pesadillas traumáticas y la mejoría de la calidad del sueño en pacientes con TEPT. Las benzodiacepinas como Diazepam (B) están contraindicadas porque alteran la arquitectura del sueño REM y aumentan la desensibilización negativa. El haloperidol (C) y el metilfenidato (E) no tienen indicación en este escenario. Perla de examen: Prazosina es el fármaco de elección para el tratamiento de las pesadillas traumáticas e insomnio del TEPT.

PREGUNTA 49 **Respuesta: C**

5.01.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo

Trastorno por estrés agudo

PREGUNTA 50 **Respuesta: A**

5.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo

De libro y lleva más de 4 semanas.

PREGUNTA 51 **Respuesta: B**

Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo

5.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un TEPT clásico.

PREGUNTA 52 **Respuesta: A**

Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo

5.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Trastorno por estrés postraumático.

PREGUNTA 53 **Respuesta: E**

Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo

5.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Trastorno por estrés postraumático.

PREGUNTA 54 **Respuesta: C**

Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo

5.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Trastorno por estrés postraumático.

BLOQUE 4 TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: A** **Enuresis**

5.01.1.026 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Enuresis" (5.01.1.026), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 56 **Respuesta: B**

Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve

4.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La paciente presenta una idea delirante estructurada (persecutoria con tinte somático) que persiste por más de 1 mes (4 meses de evolución) en ausencia de los síntomas cardinales de esquizofrenia (no hay alucinaciones auditivas, disgregación del lenguaje ni síntomas negativos como abulia o aplanamiento) y con conservación intacta del funcionamiento profesional y social fuera de la temática del delirio. Corresponde clásicamente a un Trastorno Delirante Crónico. La esquizofrenia (A) cursa con disfunción sociolaboral global y síntomas negativos. El trastorno psicótico breve (C) dura menos de 30 días. Perla de examen: La conservación de la funcionalidad laboral e interpersonal fuera de la temática delirante es el sello característico del Trastorno Delirante Crónico.

PREGUNTA 57 **Respuesta: B**

Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve

4.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El cuadro se inició bruscamente tras un estresor biográfico masivo (pérdida del sustento laboral en un incendio), cursó con síntomas psicóticos floridos (alucinaciones, delirio, desorganización) y se resolvió completamente con restitución ad integrum a los 18 días de evolución (dentro del rango temporal menor a 1 mes). El diagnóstico DSM-5 definitivo es Trastorno Psicótico Breve con desencadenante grave (anteriormente llamado psicosis reactiva breve). El trastorno esquizofreniforme (C) requiere una duración de entre 1 y 6 meses. La esquizofrenia (A) requiere al menos 6 meses de signos continuos. Perla de examen: El trastorno psicótico breve dura menos de 30 días y se resuelve con restitución completa al estado premórbido.

PREGUNTA 58 **Respuesta: B**

1.13.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo

El paciente presenta la presentación clásica del Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): hipertermia severa, rigidez muscular plástica en caño de plomo, inestabilidad autonómica, compromiso de conciencia y elevación masiva de la CPK con leucocitosis en contexto de uso de antipsicóticos típicos. La primera medida obligatoria y vital es la suspensión inmediata del fármaco bloqueador dopaminérgico (Haloperidol) y el traslado a UPC para soporte hemodinámico e hidratación endovenosa agresiva para prevenir la falla renal por rabdomiólisis. Mantener el antipsicótico o aumentarlo (A y E) es una conducta mortal. El biperideno (C) no es efectivo para el SNM. Perla de examen: En el SNM, suspender de inmediato el antipsicótico es la primera medida innegociable.

PREGUNTA 59 **Respuesta: B**

1.13.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo

El cuadro corresponde a un Síndrome Serotoninérgico desencadenado por la interacción farmacológica entre un ISRS (Paroxetina) y un analgésico opioide con potente inhibición de la recaptación de serotonina (Tramadol). Los criterios diagnósticos de Hunter establecen que la presencia de clonus (inducible, espontáneo u ocular) asociado a agitación, diaforesis, diarrea e hiperreflexia patológica es diagnóstica de toxicidad serotoninérgica. Esta hiperreflexia y clonus contrastan nítidamente con el Síndrome Neuroléptico Maligno, en el cual predomina la rigidez muscular continua en caño de plomo con reflejos osteotendinosos disminuidos o abolidos y sin diarrea. Perla de examen: La hiperreflexia osteotendinosa y el clonus diferencian al Síndrome Serotoninérgico de la rigidez en caño de plomo del Síndrome Neuroléptico Maligno.

PREGUNTA 60 **Respuesta: B**

1.13.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo

En el Síndrome Neuroléptico Maligno, la contracción muscular sostenida y tónica produce rabdomiólisis masiva con liberación de grandes cantidades de mioglobina y enzimas musculares a la sangre (CPK > 20.000 UI/L). La mioglobina precipita en los túbulos renales formando cilindros que causan obstrucción intratubular y toxicidad tubular oxidativa directa, lo que desencadena una necrosis tubular aguda oligúrica grave que históricamente constituía la causa primaria de muerte. La fluidoterapia agresiva con suero salino isotónico (3 a 6 L/día) busca expandir el volumen intravascular y mantener un flujo urinario elevado (meta 2 a 3 mL/kg/h) para arrastrar la mioglobina antes de que precipite, salvaguardando la función renal. Perla de examen: La meta de la fluidoterapia en el SNM con rabdomiólisis es forzar diuresis para evitar la falla renal por mioglobina.

PREGUNTA 61 **Respuesta: A**

1.13.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo

En los casos graves, refractarios o con hipertermia extrema de Síndrome Neuroléptico Maligno, los dos fármacos con indicación formal de rescate son: 1) Dantroleno sódico endovenoso (relajante muscular de acción periférica que bloquea los canales de rianodina inhibiendo la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico y deteniendo el hipermetabolismo muscular); y 2) Bromocriptina (agonista de los receptores dopaminérgicos D2 que restaura el tono dopaminérgico central en el hipotálamo y los ganglios basales). El flumazenil (B) es para sobredosis de benzodiacepinas. La naloxona (C) es para intoxicación por opioides. El haloperidol (D) está estrictamente proscrito por ser la causa del cuadro. La ciproheptadina (E) es para síndrome serotoninérgico. Perla de examen: Dantroleno EV y Bromocriptina son los fármacos de rescate específicos en el SNM refractario.

PREGUNTA 62 **Respuesta: A**

1.09.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada

La combinación de Haloperidol 5 mg IM con Lorazepam 2 a 4 mg IM es el estándar de oro en los servicios de urgencia para el manejo de la agitación psicomotora severa no orgánica. La sinergia entre el antipsicótico (bloqueo D2 rápido) y la benzodiacepina (agonismo gabaérgico ansiolítico y sedante) permite una sedación conductual más veloz y eficaz con menores dosis de cada agente, con la enorme ventaja adicional de que el Lorazepam previene la aparición de distonías agudas inducidas por el haloperidol. La alternativa B comete un error mortal: asociar Olanzapina IM con Lorazepam IM está formalmente contraindicado por riesgo de depresión cardiorrespiratoria e hipotensión severa fatal. Los demás fármacos no tienen indicación en este contexto. Perla de examen: Haloperidol 5 mg IM + Lorazepam 2 mg IM es la combinación de elección en urgencias para la agitación psicomotora.

PREGUNTA 63 **Respuesta: B**

Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada

1.09.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente presenta un Delirium hiperactivo (síndrome confusional agudo caracterizado por inicio brusco, fluctuación circadiana vespertina, desorientación y alucinaciones visuales en un adulto mayor hospitalizado). El primer pilar terapéutico es identificar y tratar la causa subyacente (dolor, retención urinaria, infección urinaria, fármacos anticolinérgicos, deshidratación). Si la agitación pone en riesgo la seguridad física del paciente, el fármaco de elección es Haloperidol en dosis muy bajas (0.5 a 1 mg vía oral o intramuscular), el cual controla la psicosis confusional sin causar depresión respiratoria. Las benzodiacepinas (A) están formalmente contraindicadas en el delirium no alcohólico porque producen sedación paradójica, empeoran la confusión cognitiva y aumentan el riesgo de caídas y broncoaspiración. Perla de examen: En el delirium del adulto mayor, las benzodiacepinas están contraindicadas; el fármaco de elección es Haloperidol a dosis muy bajas (0.5-1 mg).

PREGUNTA 64 **Respuesta: B**

Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada

1.09.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Múltiples alertas de seguridad farmacológica de la FDA y de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), reflejadas en las guías del MINSAL, prohíben estrictamente la administración parenteral simultánea de Olanzapina IM junto con Benzodiacepinas parenterales (como Lorazepam IM o Diazepam EV/IM). La coadministración parenteral de ambos fármacos deprime de forma sinérgica y fulminante los centros bulbares cardiorrespiratorios, produciendo bradicardia extrema, hipotensión severa, paro respiratorio y muerte súbita. Si se administra Olanzapina IM, deben transcurrir al menos 2 horas antes de considerar el uso de una benzodiacepina. En cambio, Haloperidol + Lorazepam IM (A) es una combinación segura y ampliamente avalada. Trampa mortal de examen: Nunca coadministrar Olanzapina IM con benzodiacepinas parenterales por riesgo de paro cardiorrespiratorio fatal.

PREGUNTA 65 **Respuesta: B**

Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada

1.09.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La contención mecánica es una medida terapéutica de última instancia regulada estrictamente por la Ley N° 21.331 (del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental). Sus exigencias legales y clínicas innegociables son: 1) Indicación médica formal, fundada y escrita en la ficha clínica con hora de inicio; 2) Supervisión médica y de enfermería continua con registro cada 15 a 30 minutos de signos vitales, nivel de conciencia y perfusión de extremidades; 3) Retiro precoz y progresivo apenas ceda la agitación; 4) El paciente DEBE colocarse en decúbito supino con cabecera elevada a 30-45° (nunca prono por riesgo de asfixia posicional [C]); y 5) Las sujeciones deben fijarse a la estructura fija de la cama, nunca a barandas móviles (E). Perla de examen: La contención física requiere orden médica escrita obligatoria y monitorización de pulsos y signos vitales cada 15 a 30 minutos.

PREGUNTA 66 **Respuesta: D**

Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada

5.01.2.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Con agitación y agresividad solo verbal, el primer escalón es la contención verbal y ambiental; la contención física o farmacológica se reserva para riesgo inminente o falla de lo anterior.

PREGUNTA 67 **Respuesta: B**

Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta la tríada clásica de la Encefalopatía de Wernicke (oftalmoplejía/nistagmo, ataxia y confusión/sopor) agravada por hipoglicemia severa. La regla de oro absoluta e innegociable en urgencias es que en todo paciente con alcoholismo crónico o desnutrición severa, la administración de TIAMINA (Vitamina B1, 100 a 300 mg EV o IM) DEBE preceder o administrarse de forma estrictamente simultánea al suero glucosado. Administrar glucosa sola (A) consume la escasa tiamina de reserva como cofactor metabólico, precipitando la necrosis hemorrágica irreversible de los cuerpos mamilares y el tronco encefálico (Síndrome de Korsakoff o muerte). La fenitoína (C) no previene ni trata el Wernicke. Perla de examen: La Tiamina se administra SIEMPRE antes de la glucosa en el paciente alcohólico para evitar desencadenar una encefalopatía de Wernicke irreversible.

PREGUNTA 68 **Respuesta: B**

Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En pacientes con insuficiencia hepatocelular o cirrosis hepática demostrada, las benzodiacepinas de vida media larga que dependen de la oxidación microsómica por citocromo P450 hepático (como Diazepam y Clordiazepóxido) sufren una dramática disminución en su depuración, acumulándose de forma impredecible y gatillando una encefalopatía hepática grave o coma. Por ello, la benzodiacepina de elección absoluta en pacientes cirróticos con abstinencia alcohólica es el LORAZEPAM (o alternativamente Oxazepam), ya que se metaboliza exclusivamente por glucuronidación directa, proceso que no depende del citocromo P450 y que se encuentra conservado en la cirrosis, además de carecer de metabolitos activos. Perla de examen: En abstinencia alcohólica con cirrosis hepática, el fármaco de elección es Lorazepam porque no depende del citocromo P450.

PREGUNTA 69 **Respuesta: B**

Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El cuadro corresponde típicamente a una Alucinosis Alcohólica: complicación de la abstinencia alcohólica que aparece en las primeras 12 a 24 horas del cese de consumo, caracterizada por la presencia de alucinaciones auditivas o visuales vívidas en un paciente con SENSORIO RIGUROSAMENTE LÚCIDO Y PLENA ORIENTACIÓN témporo-espacial. Esta lucidez de la conciencia es la diferencia cardinal con el Delirium Tremens (A), el cual ocurre más tardíamente (48-72 h) y se define obligatoriamente por confusión global, desorientación, estupor y grave inestabilidad autonómica. La esquizofrenia (C) exige al menos 6 meses de evolución. Perla de examen: La alucinosis alcohólica cursa con sensorio lúcido y orientado; el delirium tremens cursa con desorientación y compromiso global de conciencia.

PREGUNTA 70 **Respuesta: C**

Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

5.01.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Tiene alcoholismo y está motivado para dejar de consumir, pero Gene antecedente de un síndrome de absGnencia grave, con delirium tremens previo, por lo que lo razonable es que inicie la disconGnuación bajo supervisión médica, en el hospital. Si presentara síntomas de absGnencia grave, se trataría con Lorazepam, ya que el diazepam no se recomienda en el daño hepático crónico.

PREGUNTA 71 **Respuesta: C**

Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

5.01.1.014 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Delirium tremens: benzodiacepinas (lorazepam o diazepam) como base, más tiamina previa a glucosa y corrección electrolítica.

PREGUNTA 72 **Respuesta: A**

Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

5.01.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Retardo mental" (5.01.1.025), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

BLOQUE 5 ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 73 **Respuesta: A** **Encopresis**

5.01.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Encopresis" (5.01.1.027), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 74 **Respuesta: D**

5.01.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

Presenta un consumo perjudicial de alcohol con escasa conciencia de enfermedad (etapa precontemplativa), por lo que primero se debe trabajar la motivación al cambio. De nada sirve iniciar fármacos o derivar a psicoterapia, si no Gene intenciones de cambiar.

PREGUNTA 75 **Respuesta: C**

5.01.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

En la intoxicación por cocaína con complicaciones cardiovasculares (dolor torácico, isquemia miocárdica, hipertensión severa), los betabloqueadores puros no selectivos (como Propranolol) o selectivos (Atenolol, Metoprolol) están formalmente contraindicados. Al antagonizar los receptores beta-2 vasculares que median vasodilatación, la gran sobrecarga de noradrenalina y adrenalina circulante estimula libremente los receptores alfa-1 vasculares (fenómeno de estimulación alfa sin oposición), lo que intensifica drásticamente el vasoespasmo de las arterias coronarias y la vasoconstricción periférica, pudiendo desencadenar infarto masivo transmural, crisis hipertensiva maligna y muerte. El tratamiento de primera línea son las benzodiacepinas EV (A y E), nitratos (B) y AAS (D). Perla de examen: Los betabloqueadores puros están contraindicados en dolor torácico por cocaína por el riesgo de vasoespasmo alfa sin oposición.

PREGUNTA 76 **Respuesta: B**

5.01.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

El Flumazenil es un antagonista competitivo selectivo de los receptores GABA-A. Si bien revierte rápidamente el efecto de las benzodiacepinas en intoxicaciones agudas accidentales en pacientes sin consumo previo (ej. reversión de sedación post-endoscopía), está formalmente contraindicado o fuertemente desaconsejado en pacientes con consumo crónico de benzodiacepinas (como esta paciente con 10 años de uso de clonazepam). En estos pacientes, el bloqueo súbito del receptor GABA precipita de forma violenta un síndrome de abstinencia agudo caracterizado por convulsiones generalizadas y status epiléptico de muy difícil manejo que puede ser letal. Dado que la paciente mantiene signos vitales estables y adecuada ventilación, la conducta correcta es la observación protegida y el soporte clínico hasta que el fármaco se metabolice. Perla de examen: El flumazenil no debe usarse en sobredosis de benzodiacepinas en pacientes dependientes crónicos por riesgo de status epiléptico.

PREGUNTA 77 **Respuesta: C**

5.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

Tiene un síndrome adrenérgico: midriasis, taquicardia, hipertensión, agitación, hipertermia. La cocaína y las anfetaminas son las clásicas causas.

PREGUNTA 78 **Respuesta: B**

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C

El paciente presenta un Trastorno de la Personalidad Esquizoide (Clúster A): patrón dominante de distanciamiento de las relaciones sociales y restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal. El hallazgo distintivo es que el paciente genuinamente NO desea ni disfruta de las relaciones íntimas, muestra preferencia por actividades solitarias y manifiesta indiferencia ante la aprobación o crítica ajena, sin angustia egodistónica. En contraste, el trastorno de personalidad por evitación (A) y la fobia social (E) se caracterizan porque los pacientes sí anhelan el contacto humano, pero se aíslan por miedo angustioso al rechazo o la humillación. El esquizotípico (C) presenta pensamiento mágico y rarezas perceptivas. Perla de examen: El paciente esquizoide no tiene ningún interés en socializar; el evitativo desea amigos pero teme el rechazo.

PREGUNTA 79 **Respuesta: B**

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C

El cuadro corresponde clínicamente a un Trastorno de Personalidad Límite (Borderline), caracterizado por desregulación afectiva severa, impulsividad, automutilaciones (cortes en piel) y miedo intenso al abandono. La Terapia Dialéctico-Conductual (DBT), desarrollada específicamente por Marsha Linehan para pacientes con desregulación emocional y conductas autolesivas repetitivas, es el modelo psicoterapéutico de primera línea que cuenta con la mayor evidencia científica en ensayos clínicos aleatorizados, demostrando reducir de forma significativa los gestos parasuicidas, las consultas en urgencias y las hospitalizaciones. Los psicofármacos se usan únicamente como apoyo sintomático. La TEC (A) no está indicada para trastornos de la personalidad. Perla de examen: La Terapia Dialéctico-Conductual (DBT) es la intervención de elección para el Trastorno Límite de Personalidad.

PREGUNTA 80 **Respuesta: B**

5.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C

Es un TP limítrofe clásico.

PREGUNTA 81 **Respuesta: B**

5.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C

Cuadro clásico

PREGUNTA 82 **Respuesta: C**

5.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C

Trastorno de Personalidad Límite: El caso presentado describe un trastorno de personalidad límite clásico. Se recomienda revisar el resumen de psiquiatría.

PREGUNTA 83 **Respuesta: B**

5.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C

Es un clásico trastorno limítrofe de la personalidad.

PREGUNTA 84 **Respuesta: A**

5.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C

Cuadro clásico

PREGUNTA 85 **Respuesta: A**

5.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C

Es un trastorno evitativo clásico (inicio temprano, pocos amigos, etc.), aunque puede confundirse con una fobia social, sin embargo, en la fobia social sí tienen amigos, solo que no hacen cosas frente a ellos, en las que los puedan juzgar.

PREGUNTA 86 **Respuesta: B**

Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

4.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente cumple los criterios diagnósticos DSM-5 para Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) subtipo combinado: presencia de síntomas de inatención, hiperactividad motora e impulsividad presentes de forma continua durante más de 6 meses, que debutaron antes de los 12 años (presentes desde los 5 años) y que se manifiestan de forma consistente en al menos dos entornos diferentes (colegio y hogar), produciendo disfunción escolar. El tratamiento farmacológico de primera elección avalado por guías clínicas mundiales y MINSAL son los psicoestimulantes, específicamente el Metilfenidato, complementado con adaptaciones psicopedagógicas curriculares (programa PIE) y orientación a los padres. Perla de examen: En TDAH escolar con compromiso en dos o más entornos, el Metilfenidato es el tratamiento farmacológico de primera línea.

PREGUNTA 87 **Respuesta: B**

Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

4.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La paciente presenta una Anorexia Nervosa severa con criterios de hospitalización médica inmediata de urgencia: desnutrición crítica (IMC 13.5 < 14 kg/m²), bradicardia extrema (< 40 lpm: 34 lpm), hipotensión severa (75/45 mmHg) e hipotermia. Estas alteraciones confieren un riesgo inminente de arritmias ventriculares letales, asistolia y colapso circulatorio. La única conducta admisible es la hospitalización inmediata en cama monitorizada (pediatría/UPC), con estabilización hemodinámica y protocolo de realimentación enteral lenta y progresiva con control estricto de fósforo para prevenir el síndrome de realimentación. La fluoxetina ambulatoria (C) o el manejo en casa (A y D) constituyen una negligencia médica con desenlace potencialmente fatal. Perla de examen: En anorexia nervosa, un IMC < 14 kg/m² o bradicardia < 40 lpm obligan a la hospitalización médica inmediata en cama monitorizada.

PREGUNTA 88 **Respuesta: C**

Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

5.01.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una anorexia nerviosa clásica (anorexia nervosa en latín) con restricción alimentaria, bajo peso (IMC 16 kg/m²), minimización del problema, normalización de la delgadez y escasa conciencia de problema. Las niñas y adolescentes son el grupo en el que suele comenzar.

PREGUNTA 89 **Respuesta: A**

Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

5.01.1.030 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Trastorno conducta oposicionista desafiante" (5.01.1.030), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 90 **Respuesta: C**

Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

5.01.1.031 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trastorno de conducta: patrón repetitivo y persistente de comportamiento que viola los derechos básicos de otros o normas sociales (agresión, robo, absentismo, consumo de sustancias). Inicio antes de los 15 años. Requiere intervención multidisciplinaria.
